



MINI ATLAS DE LESÕES DO CÓLON

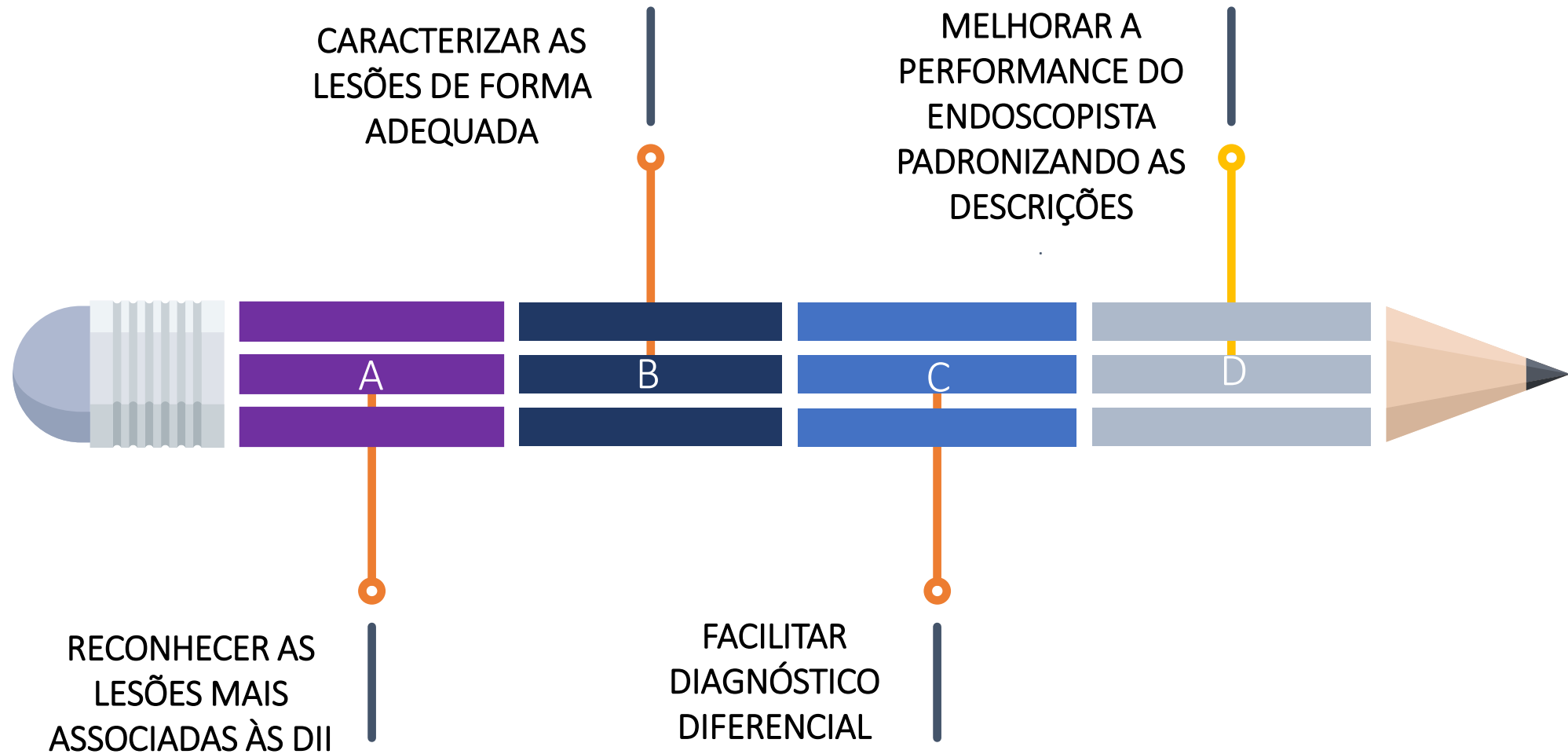
NA DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL



**ENDOSCOPIA
TERAPÊUTICA**

Licenciado para: Beatriz Teodoro | biat.rangel@hotmail.com | 10236806700 | Protegido por AlpaClass.com #M83Q5yk7zr

OBJETIVOS



REFERÊNCIAS PARA NOMENCLATURA

Journal of Crohn's and Colitis (2013) 7, 982–1018



Available online at www.sciencedirect.com

ScienceDirect



CONSENSUS/GUIDELINES

European evidence based consensus for endoscopy in inflammatory bowel disease ☆

Vito Annese ^{a,*,1,2}, Marco Daperno ^{b,2}, Matthew D. Rutter ^{c,d,2}, Aurelien Amiot ^e, Peter Bossuyt ^f, James East ^g, Marc Ferrante ^h, Martin Götz ⁱ, Konstantinos H. Katsanos ^j, Ralf Kießlich ^k, Ingrid Ordás ^l, Alessandro Repici ^m, Bruno Rosa ⁿ, Shaji Sebastian ^o, Torsten Kucharzik ^p, Rami Eliakim ^{q,**,1,2} on behalf of ECCO



GUIDELINE



The role of endoscopy in inflammatory bowel disease

Volume 81, No. 3 : 2015 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

GIE®

CONSENSUS STATEMENT



SCENIC international consensus statement on surveillance and management of dysplasia in inflammatory bowel disease

Volume 81, No. 5 : 2015 GASTROINTESTINAL ENDOSCOPY

INTRODUÇÃO



A ileocolonosopia tem um papel muito importante na DII: no diagnóstico, avaliação prognóstica, manejo de lesões e seguimento dos pacientes portadores de DII



Reconhecimento e caracterização das lesões tem papel importante nesse contexto



Usar uma terminologia padronizada na descrição das lesões permite adequado diagnóstico e diagnóstico diferencial com outras condições que mimetizam DII



NOMENCLATURA DAS LESÕES

PERDA DO PADRÃO VASCULAR



DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAR OS CAPILARES DA SUPERFÍCIE MUCOSA

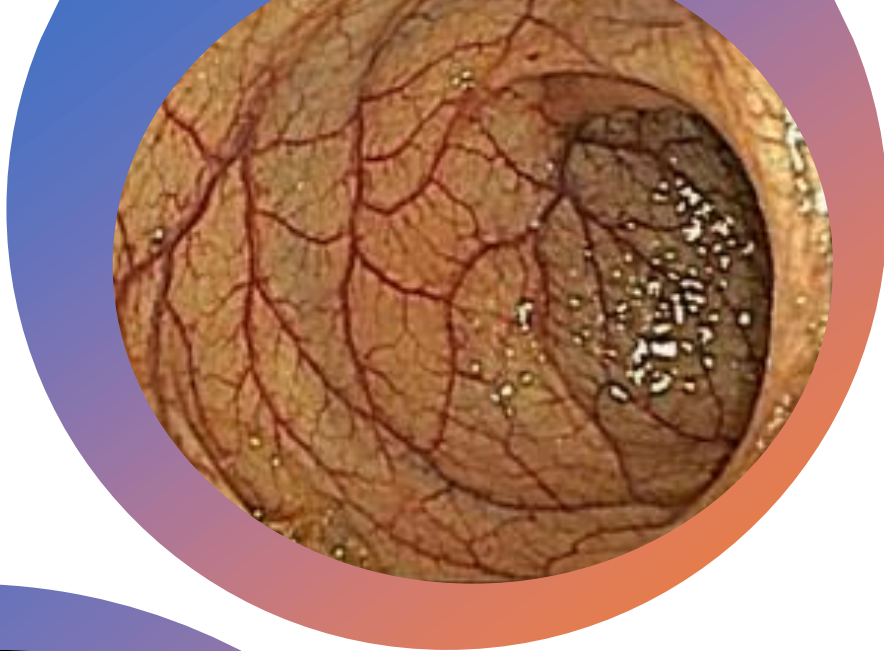


PODE SER GRADUADA: DISCRETA, BORRAMENTO DOS VASOS E DESAPARECIMENTO

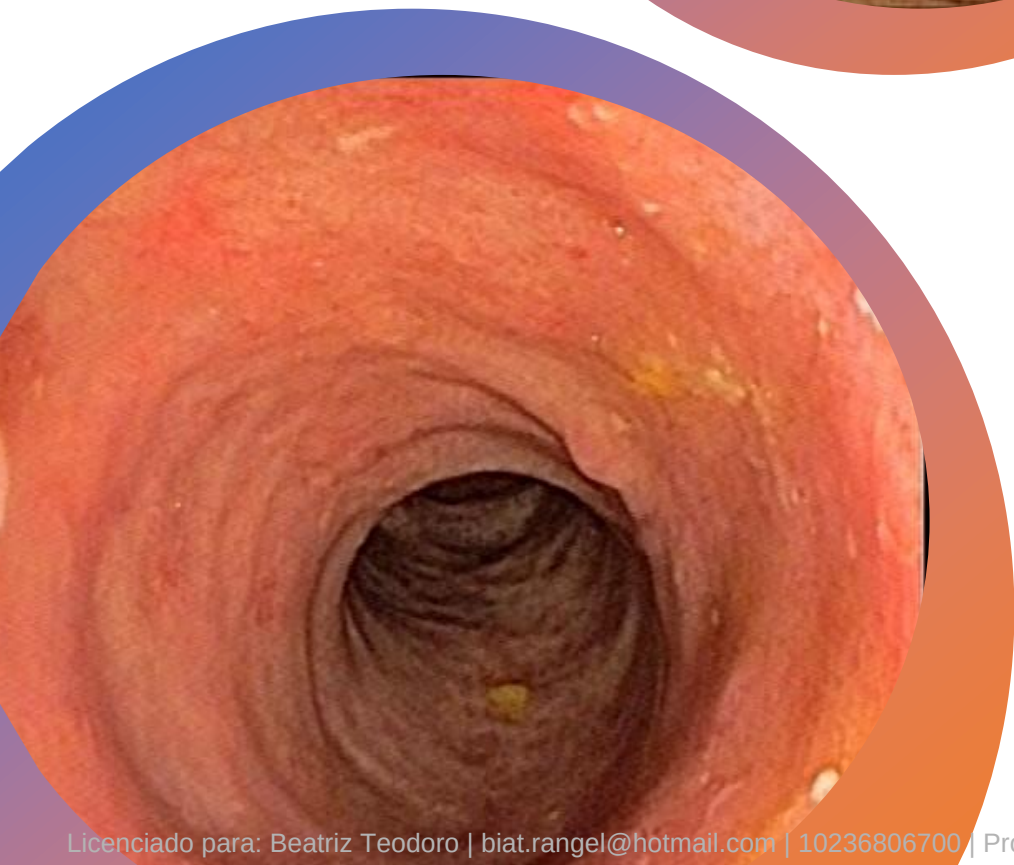


+

○



PERDA DO PADRÃO VASCULAR



PERCEBE-SE CLARAMENTE A DIFERENÇA ENTRE A MUCOSA NORMAL E A MUCOSA COM PERDA DO PADRÃO VASCULAR

●

ENANTEMA DA MUCOSA

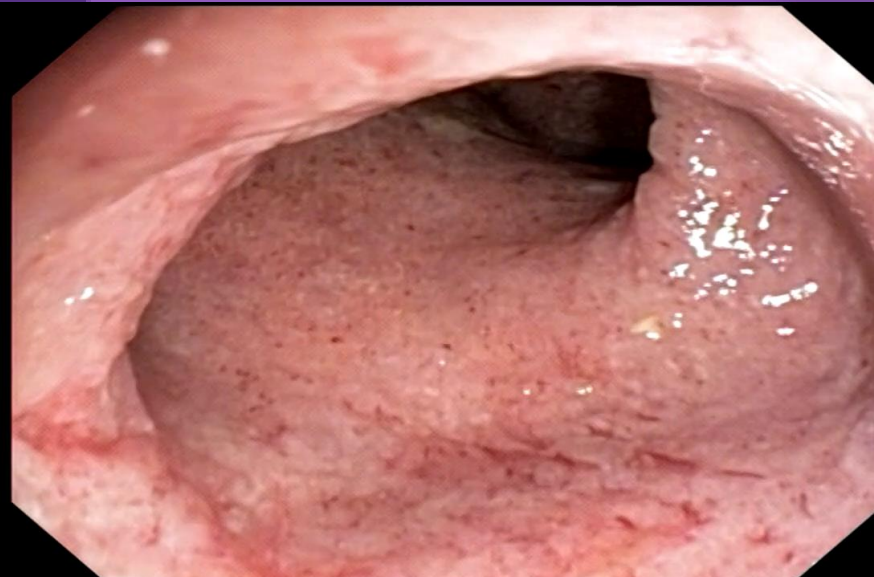
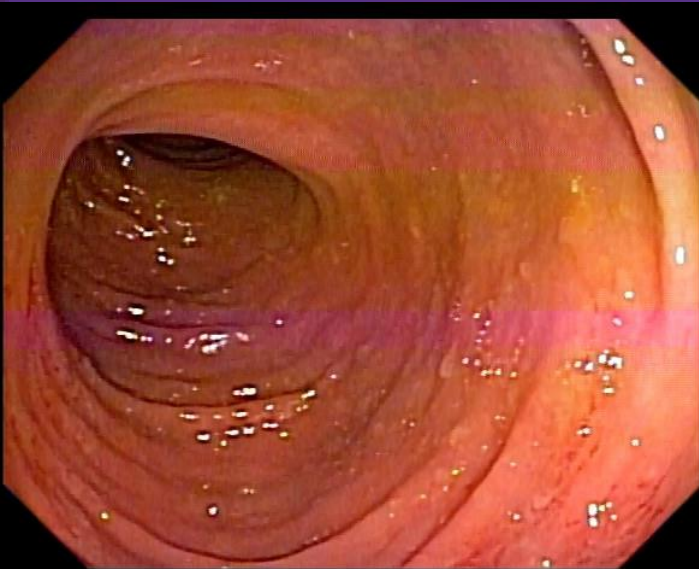
**ÁREAS COM COLORAÇÃO
VERMELHA**

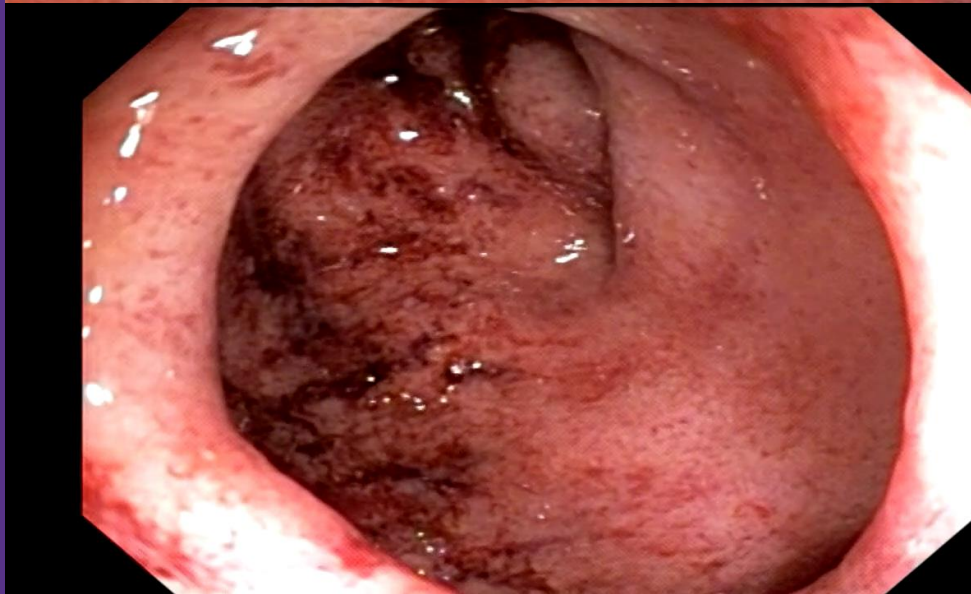
**PODE SER GRADUADO:
DISCRETO, MODERADO E
DIFUSO**



GRANULARIDADE

- ALTERAÇÃO PUNTIFORME COM PADRÃO MICRONODULAR, APRESENTANDO PONTOS DIMINUTOS DE REFLEXO DA LUZ NA MUCOSA COM 0,5 A 1 MM.
- PODE SER GRADUADO: DISCRETO ATÉ MUCOSA COM PADRÃO NODULAR





FRIABILIDADE / SANGRAMENTO

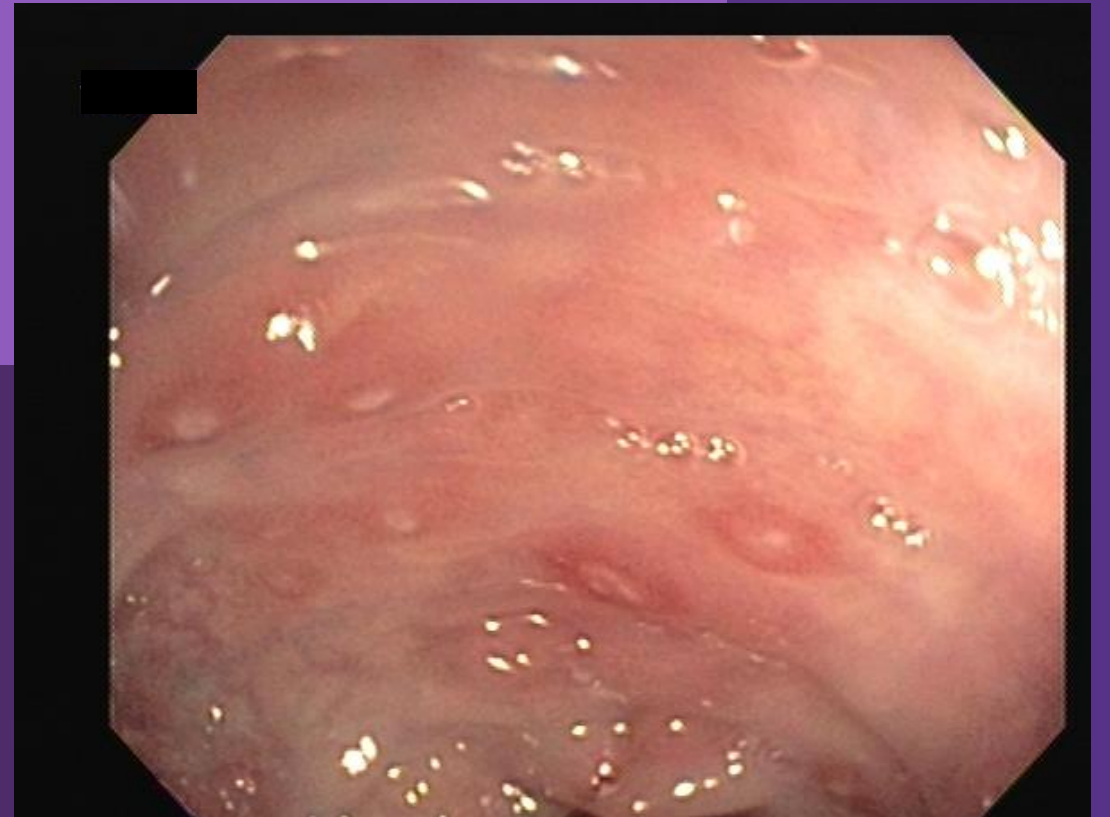
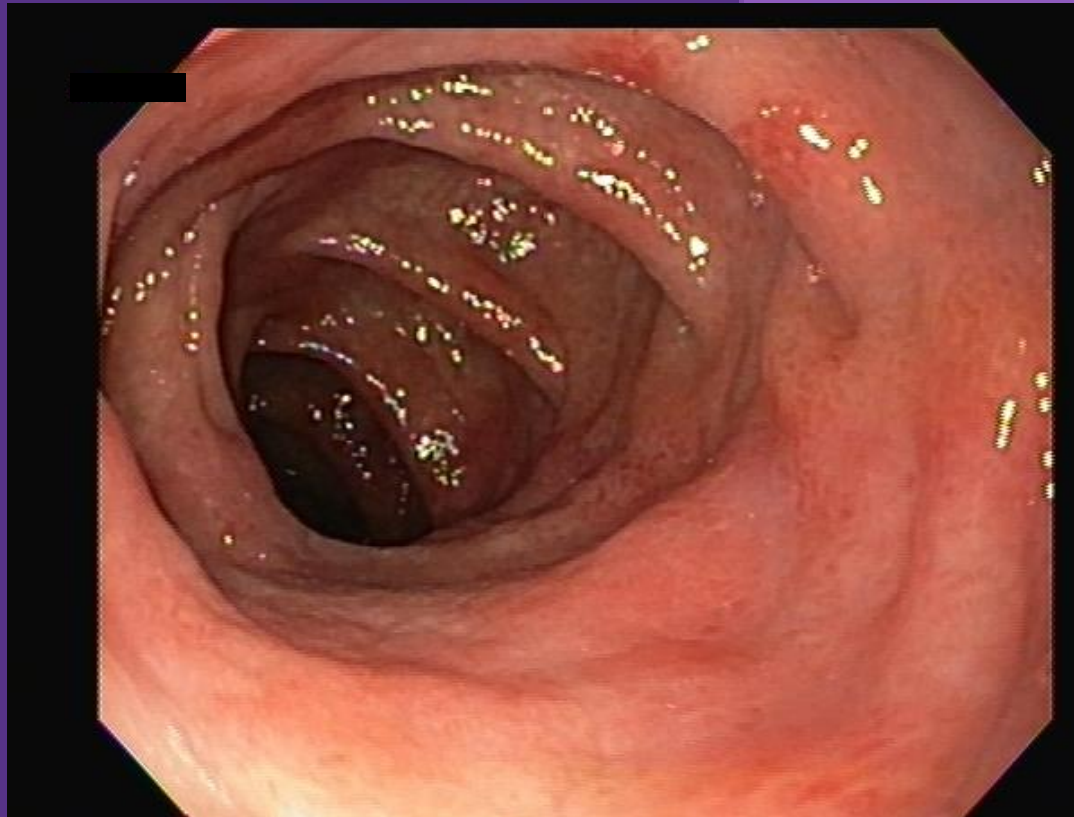
- SANGRAMENTO ESPONTÂNEO À INSUFLAÇÃO, SANGRAMENTO QUE PODE SER OBSERVADO ANTES OU APÓS A PASSAGEM DO COLONOSCÓPIO, POREJAMENTO DE SANGUE NA MUCOSA
- NA IMAGEM PODEMOS OBSERVAR O PADRÃO DE GRANULARIDADE E A FRIABILIDADE ASSOCIADA.

EROSÃO

- PERDA DE CONTINUIDADE DA MUCOSA COM ATÉ 5 MM
- PODE SER ISOLADA
- PODE SE APRESENTAR COMO DISTRIBUIÇÃO DIFUSA



EXEMPLOS DE EROSÕES

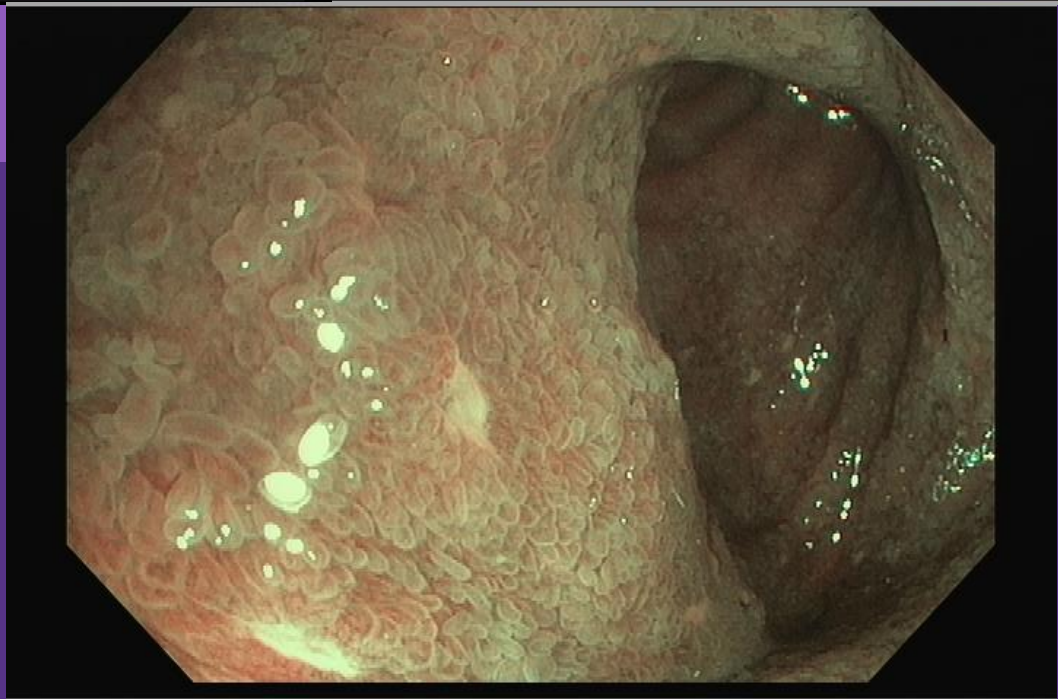
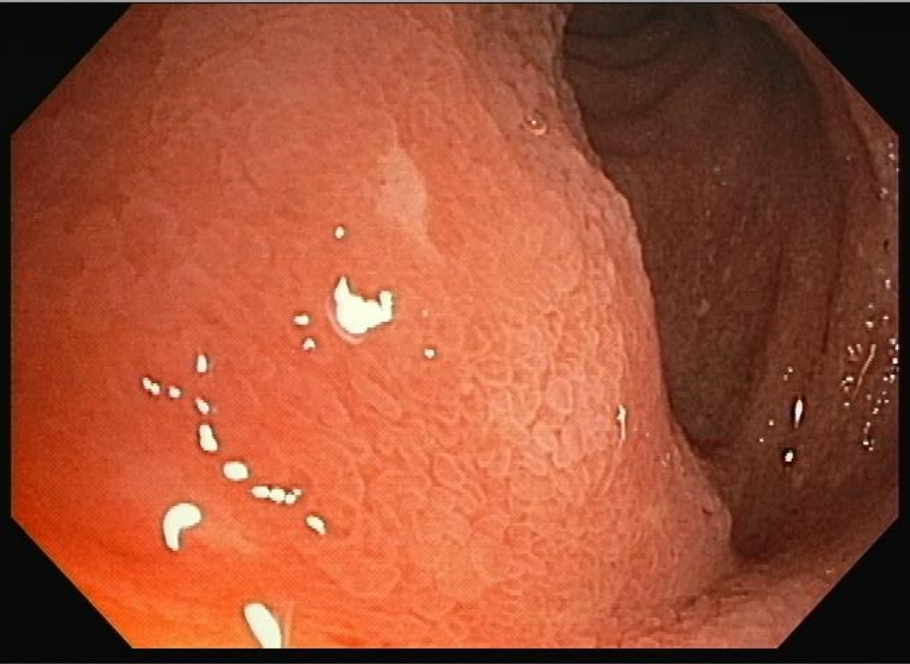


ÚLCERAS AFTOIDES

- ÚLCERAS COM CENTRO RECOBERTO POR FIBRINA, DEPRIMIDO, ASSOCIADAS A HALO DE ENANTEMA, GERALMENTE COM TAMANHO LIMITADO A 5 MM
- PODEM SER ISOLADAS OU MÚLTIPLAS



ÚLCERAS AFTOIDES



ÚLCERAS

PERDA DE CONTINUIDADE
DA MUCOSA

EFEITO DE RELEVO
DEPRIMIDO

FUNDO RECOBERTO POR
FIBRINA

FORMATOS E TAMANHOS
VARIADOS

ASSOCIADAS OU NÃO COM
HALO DE ENANTEMA



MUITO IMPORTANTE!

DESCREVER TAMAMHO DAS ÚLCERAS: ATÉ 5 MM,
ENTRE 5 E 20 MM, MAIORES DO QUE 20 MM

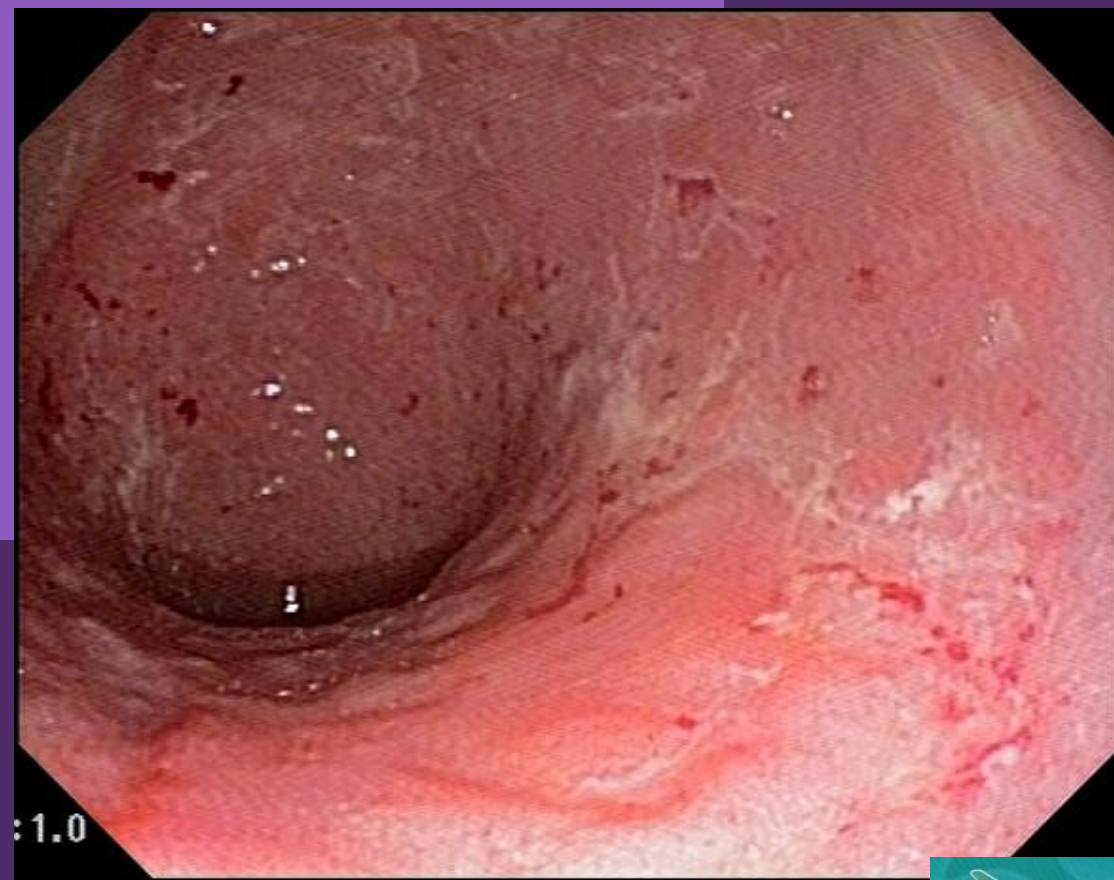
DESCREVER A PROFUNDIDADE DAS ÚLCERAS:
SUPERFICIAIS OU PRONFUNDAS

DESCREVER SE OS BORDOS SÃO BEM DEFINIDOS OU
NÃO



ÚLCERAS SUPERFICIAIS PEQUENAS E PROFUNDAS, ASSOCIADAS
A EDEMA, ENANTEMA E FRIABILIDADE DA MUCOSA

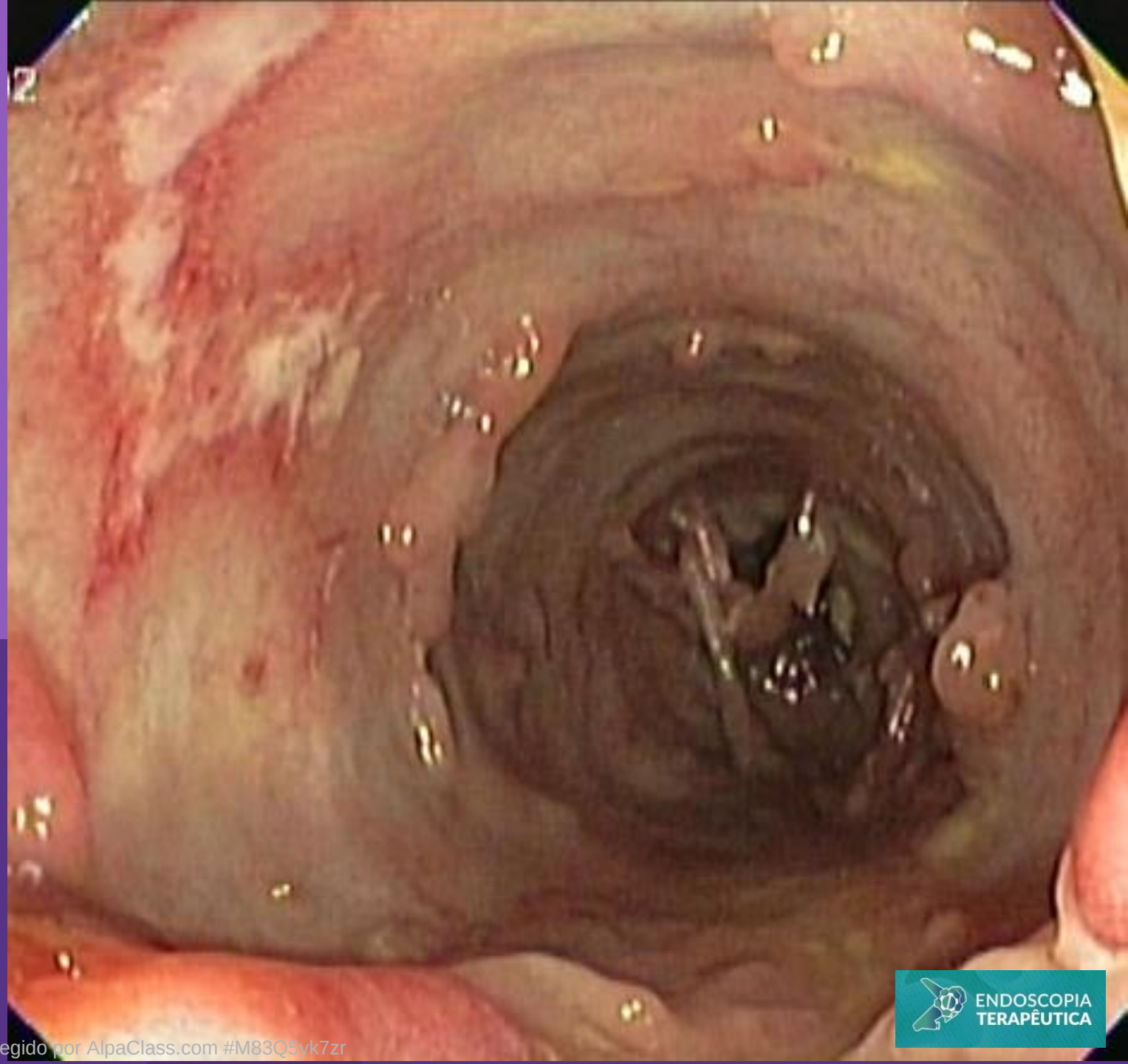
ÚLCERAS SUPERFICIAIS SERPIGINOSAS ASSOCIADAS COM EDEMA DE MUCOSA E FRIABILIDADE

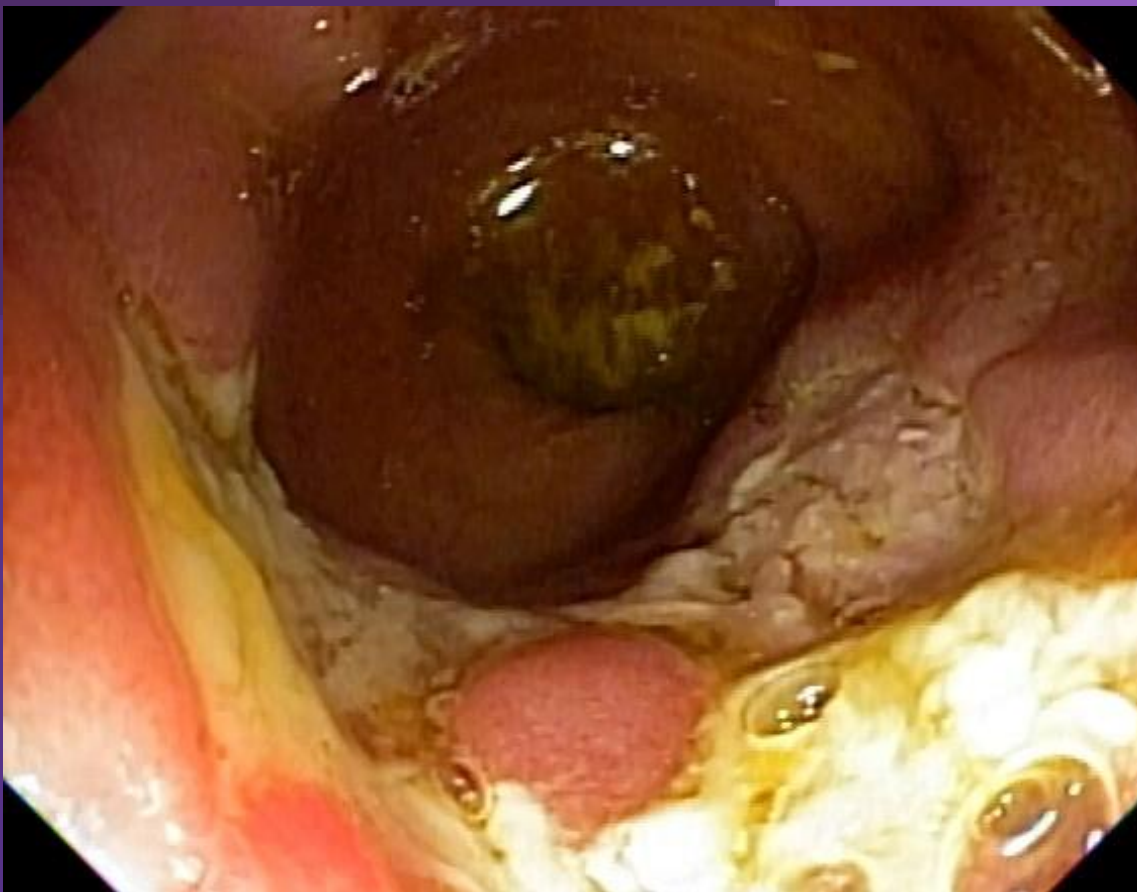


ÚLCERAS SUPERFICIAIS



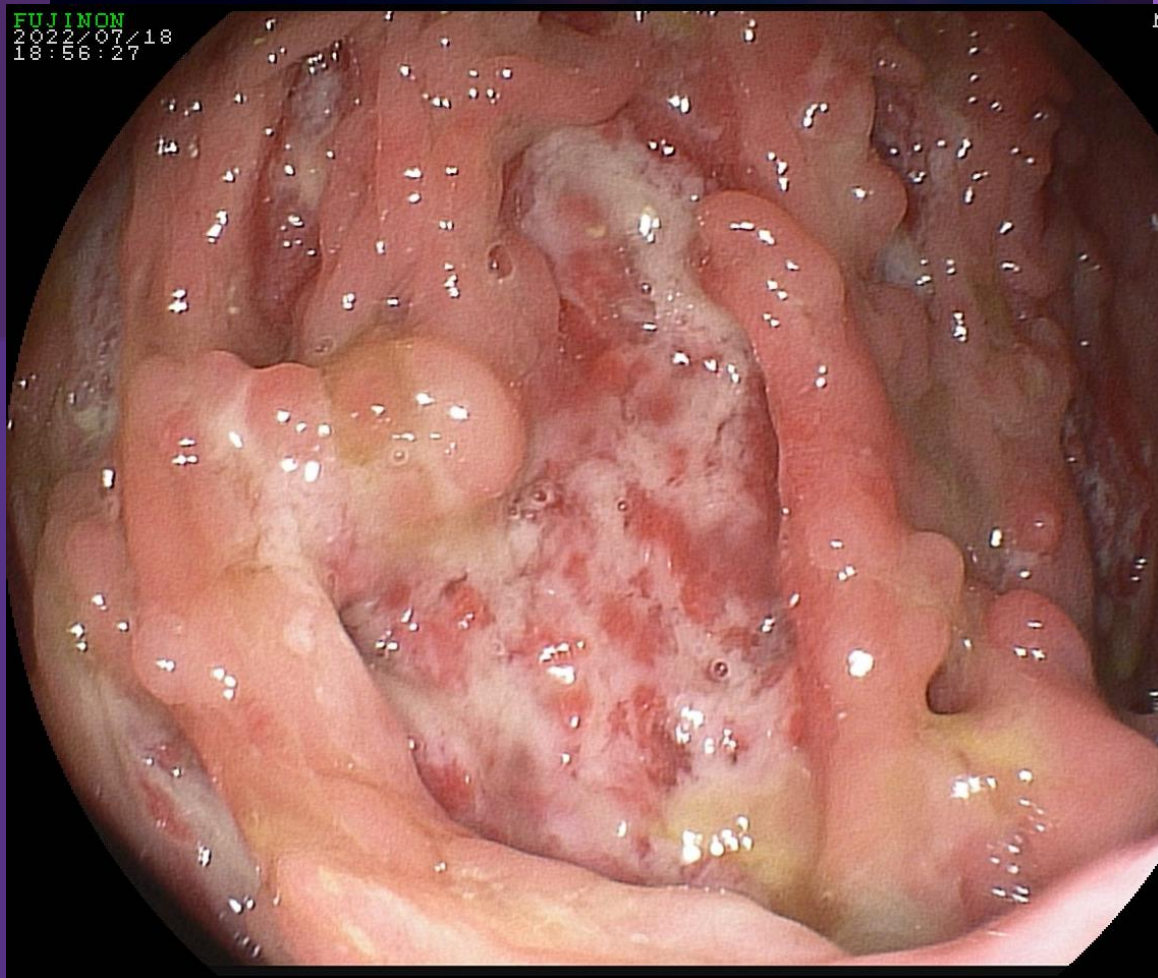
ÚLCERAS SUPERFICIAIS EXTENSAS



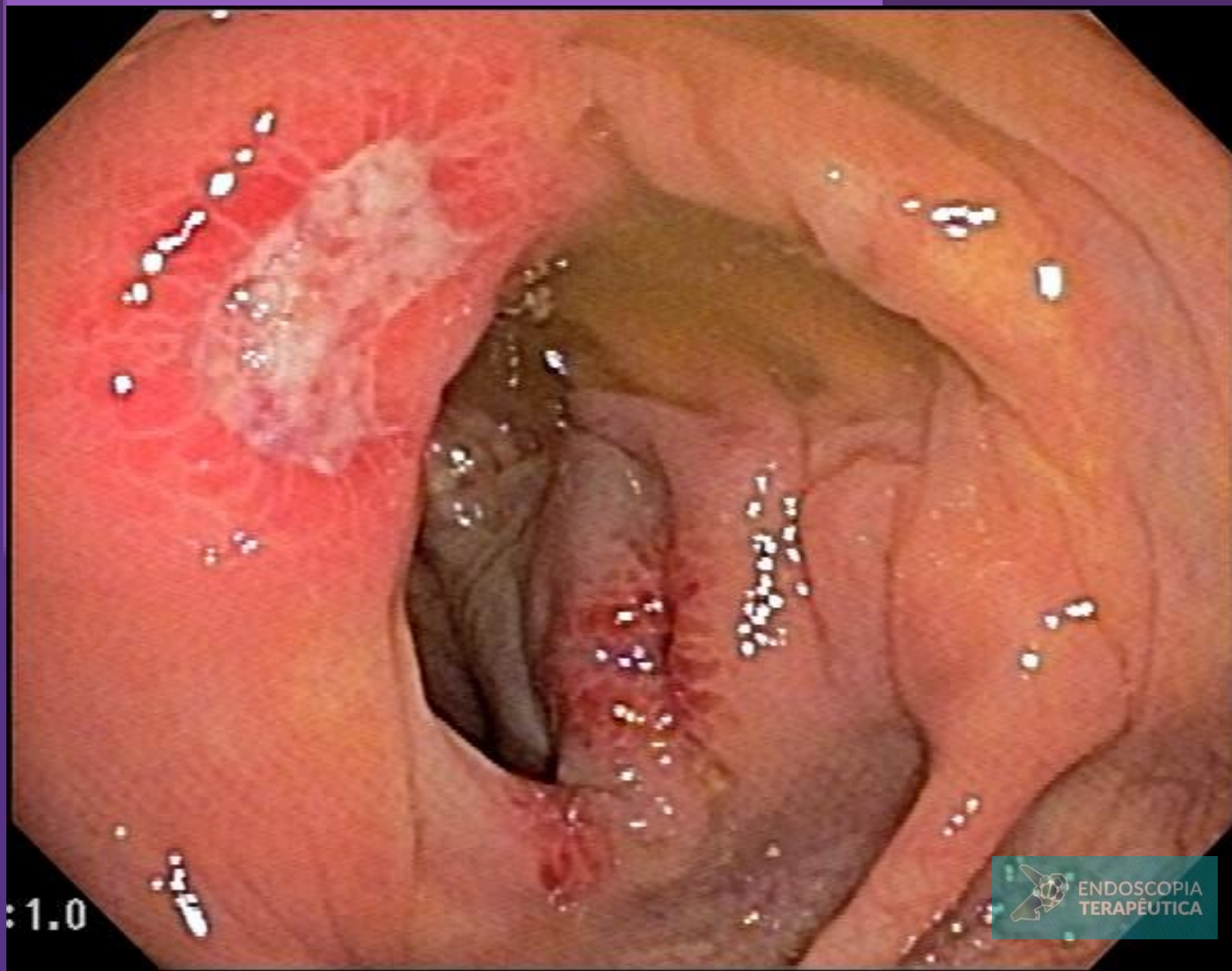


ÚLCERAS PROFUNDAS GRANDES, LARGAS E LONGITUDINAIS

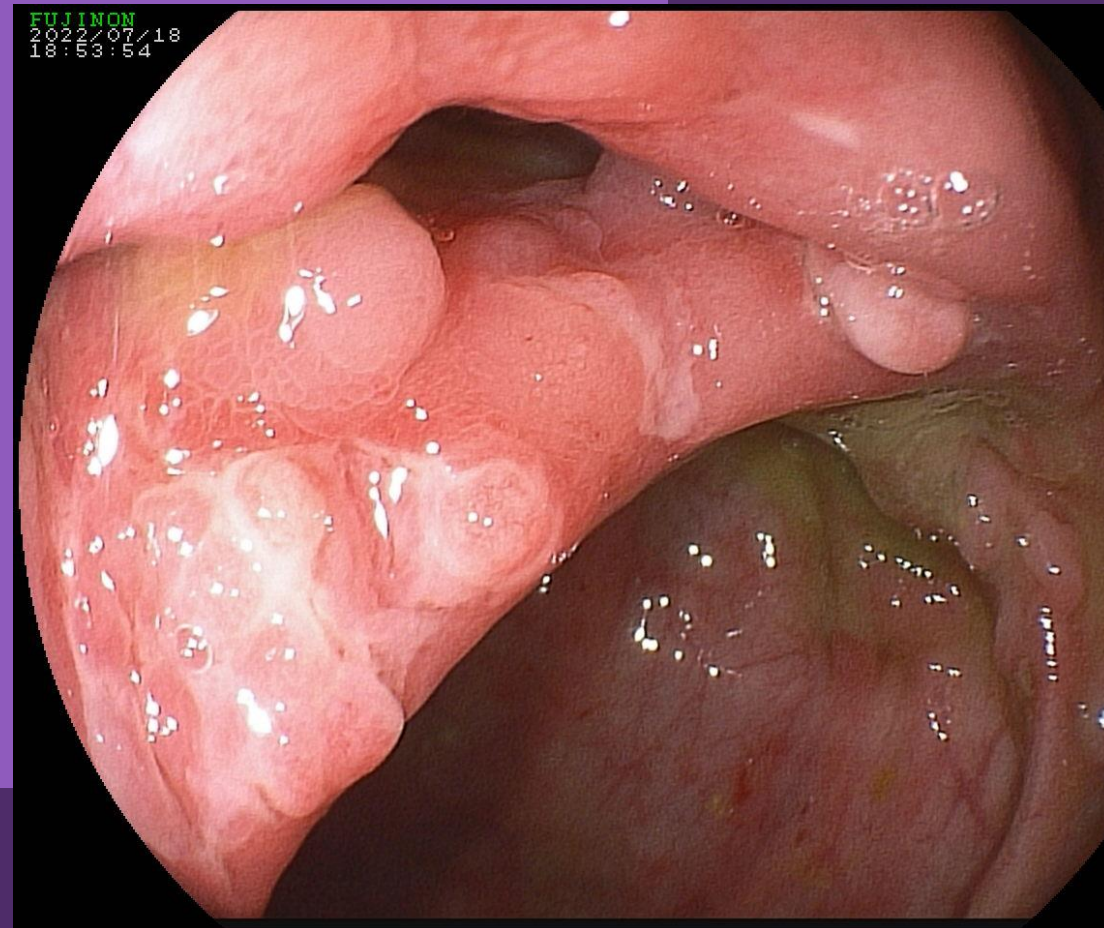
ÚLCERAS PROFUNDAS GRANDES E ARREDONDADAS



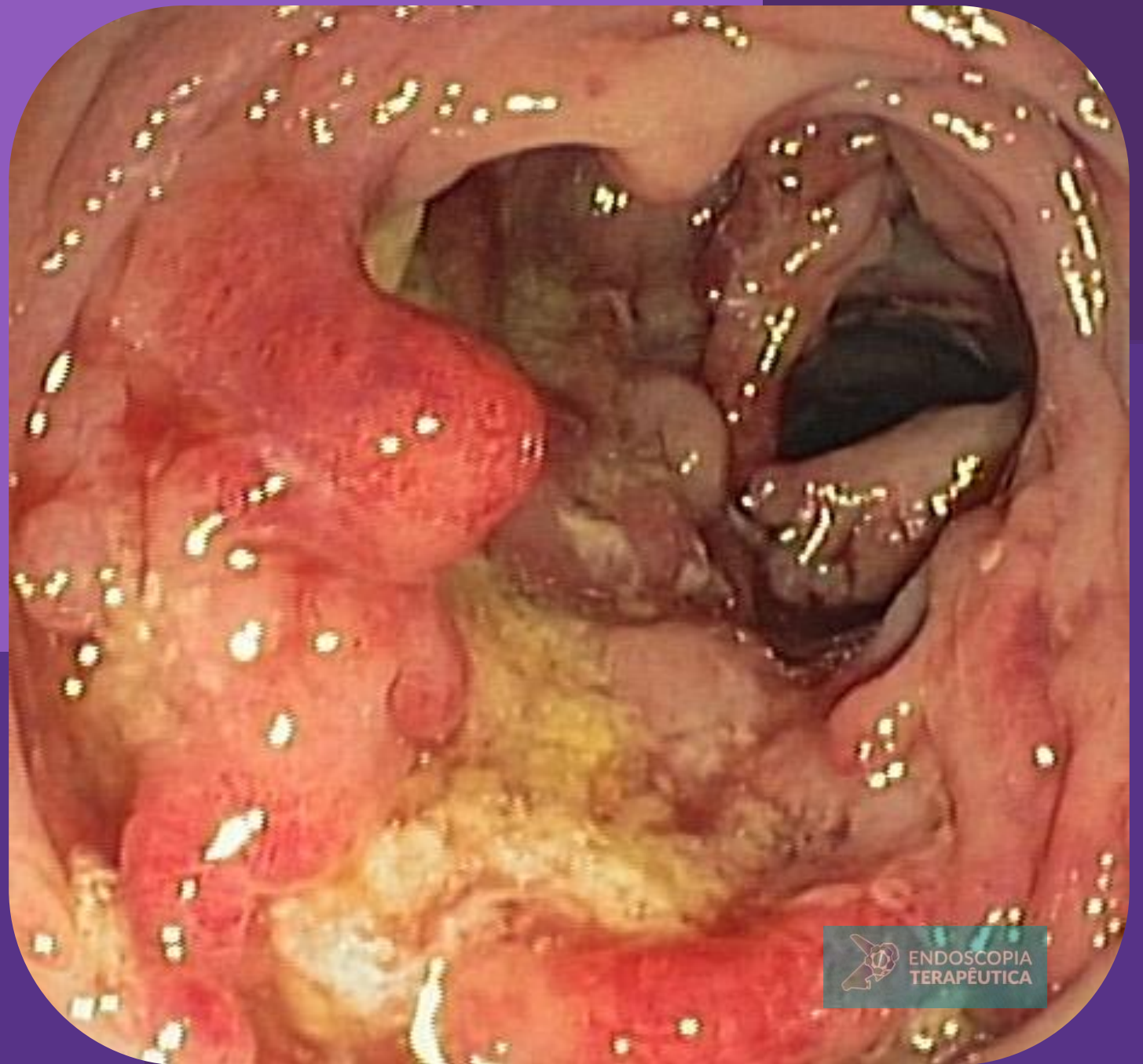
ÚLCERAS
PROFUNDAS
NO CECO E
NA VÁLVULA
ILEOCECAL



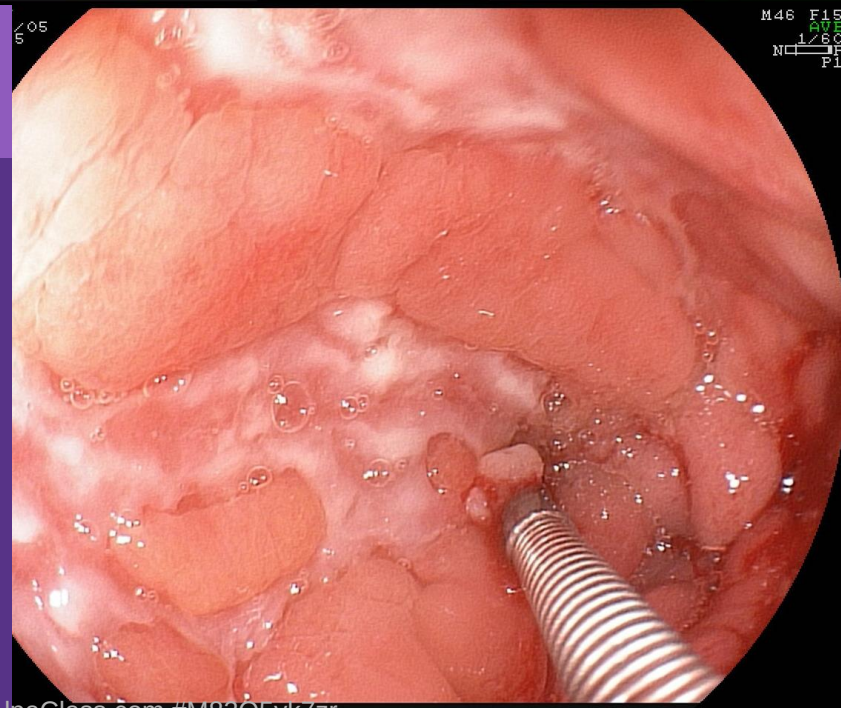
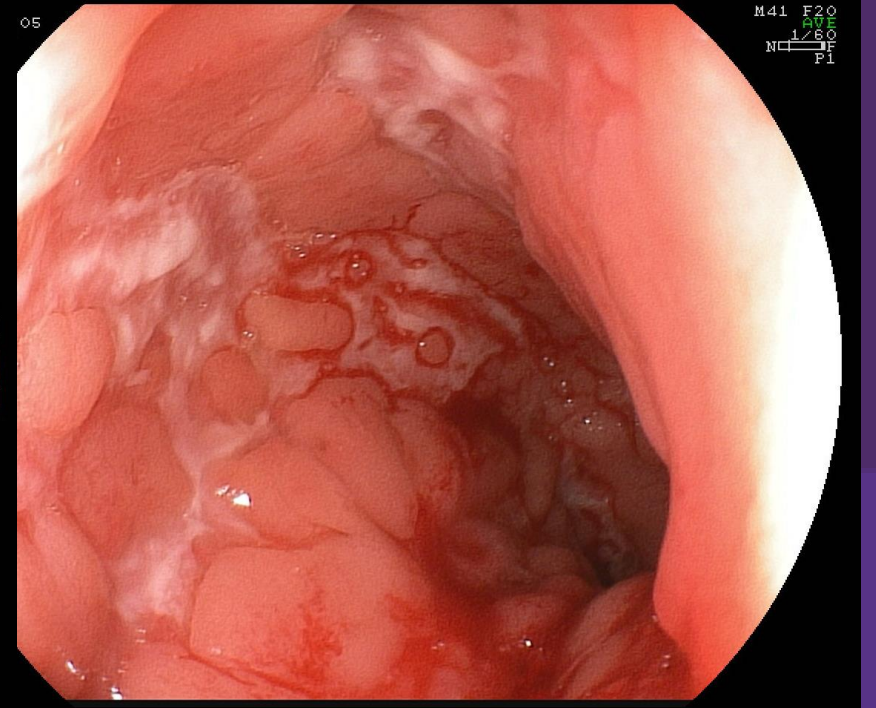
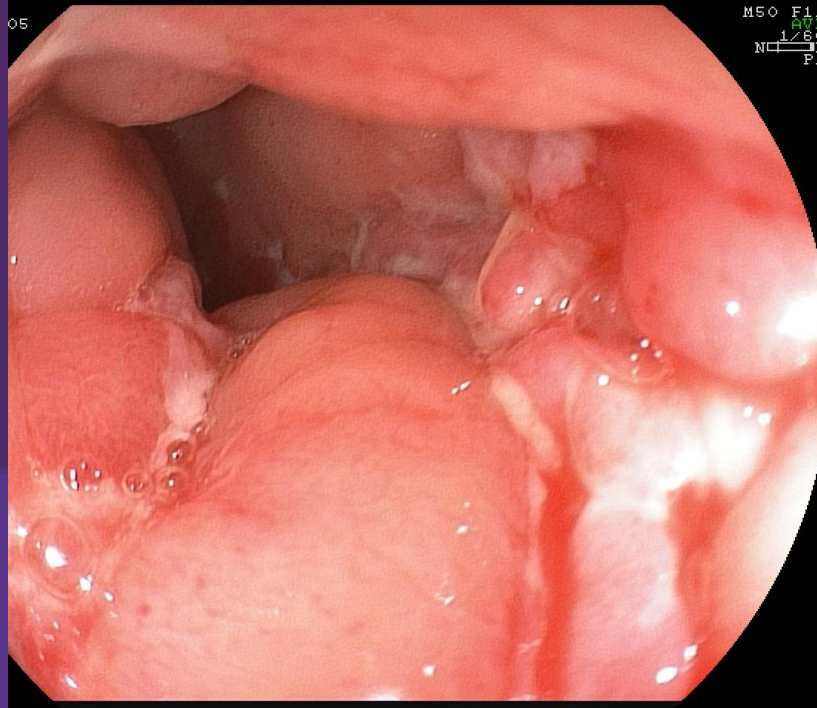
DEFORMIDADE E ULCERAÇÕES EM VÁVULA ILEOCECAL



ÚLCERAS PROFUNDAS



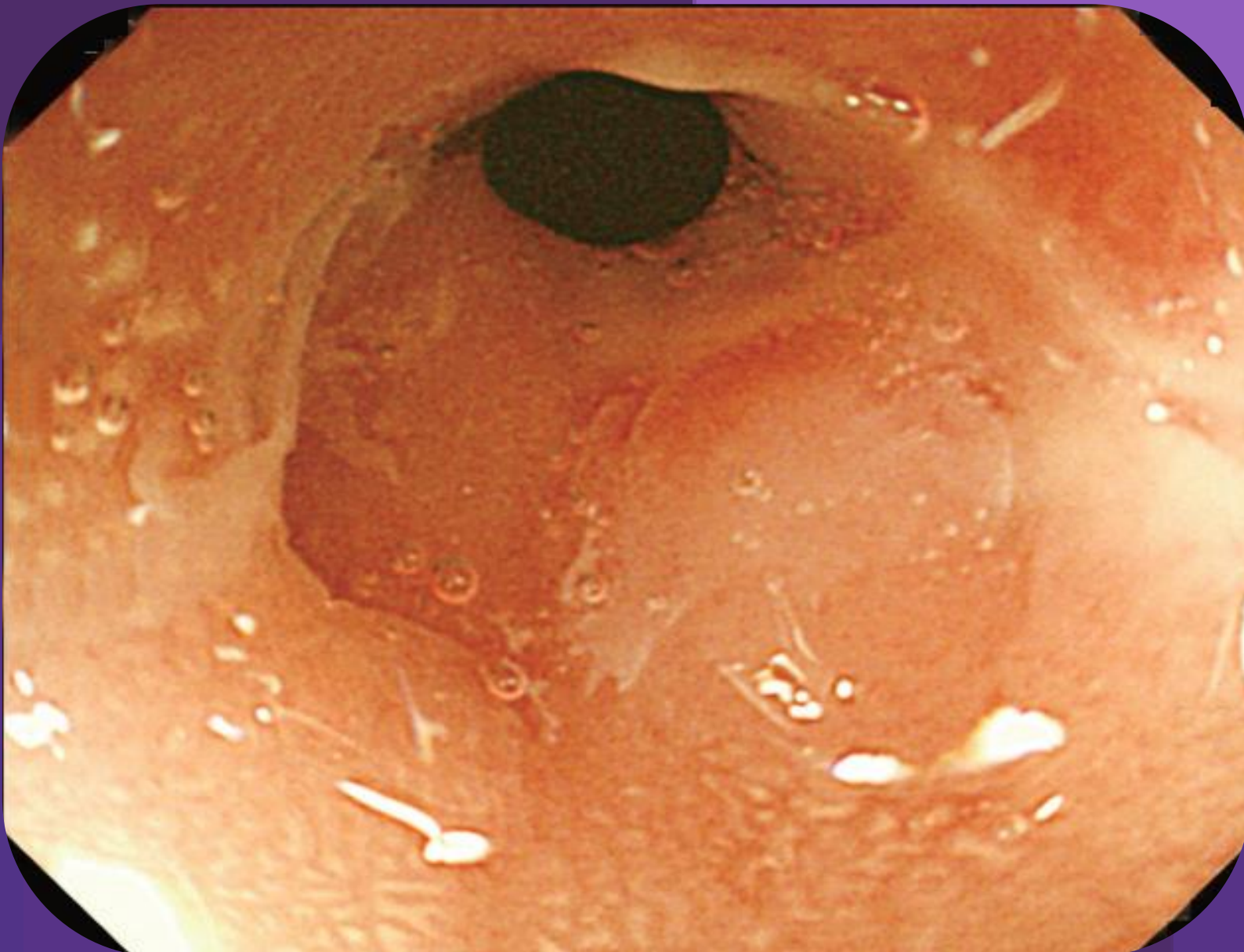
ÚLCERAS ILEAIS



ESTENOSE

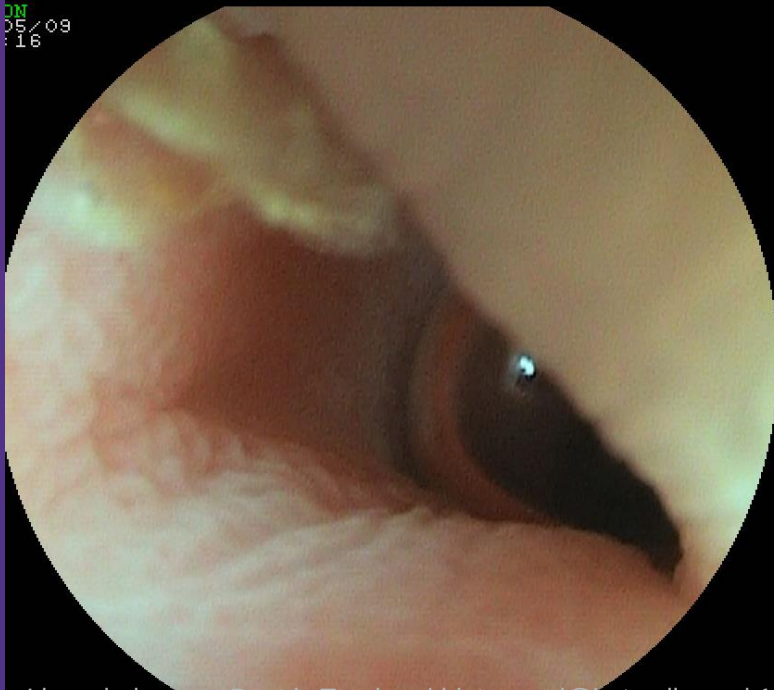
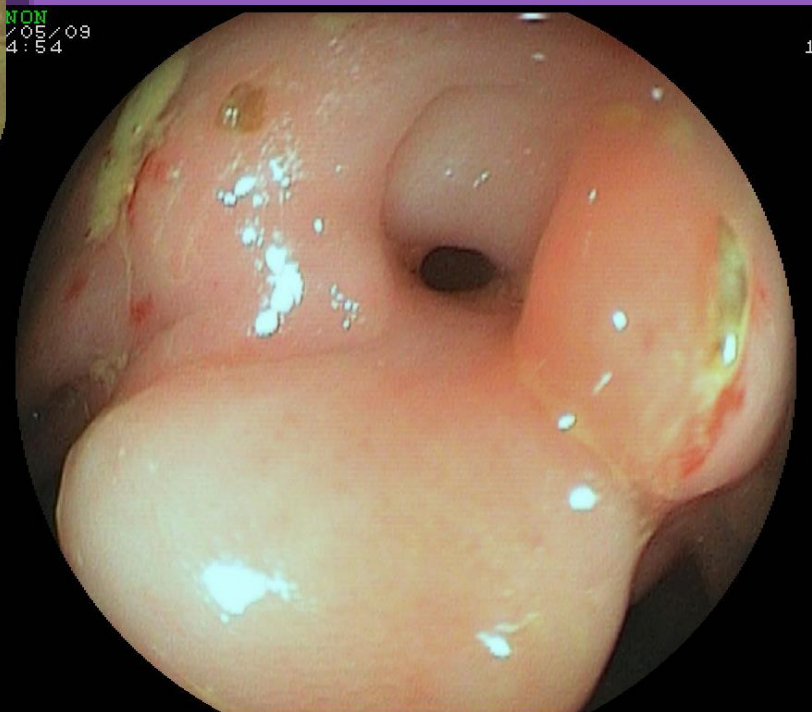
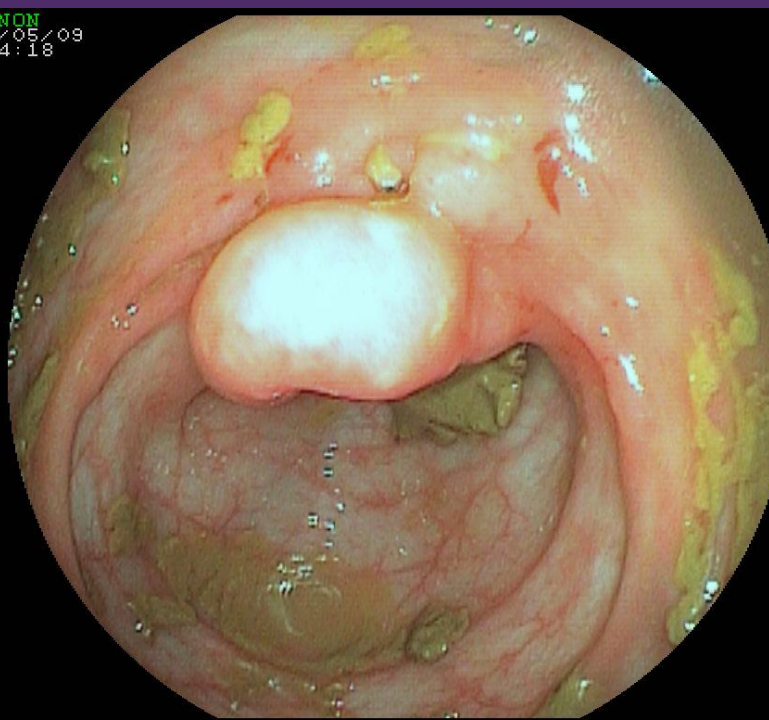
REDUÇÃO NO CALIBRE DO CÓLON

- PODE SER ÚNICA
- PODEM SER MÚLTIPLAS
- PODEM SER TRASPONÍVEIS OU NÃO
- PODE ESTAR ASSOCIADA A ULCERAÇÃO

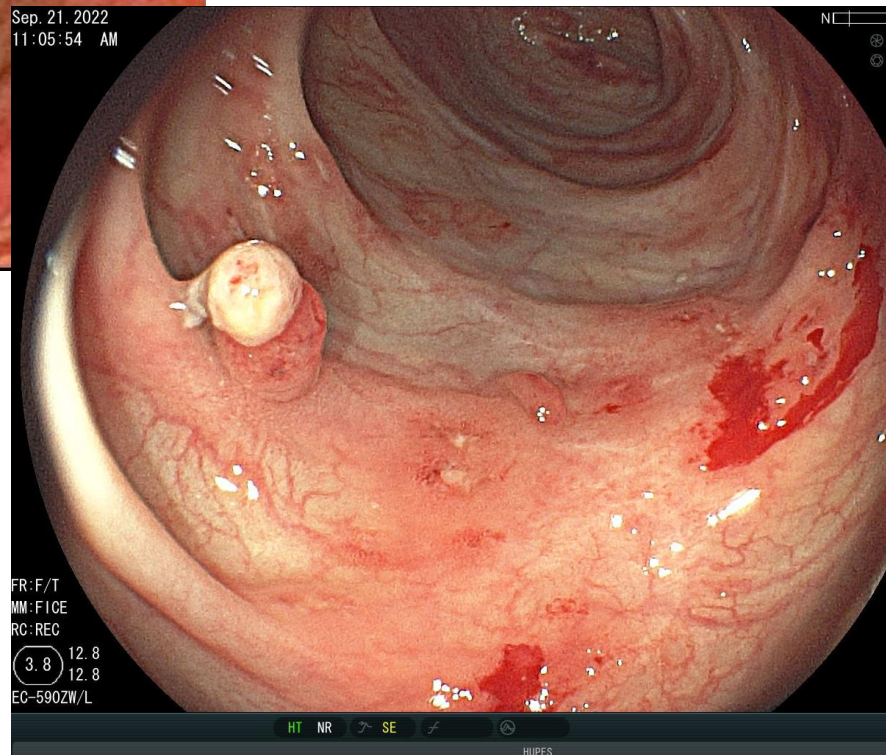
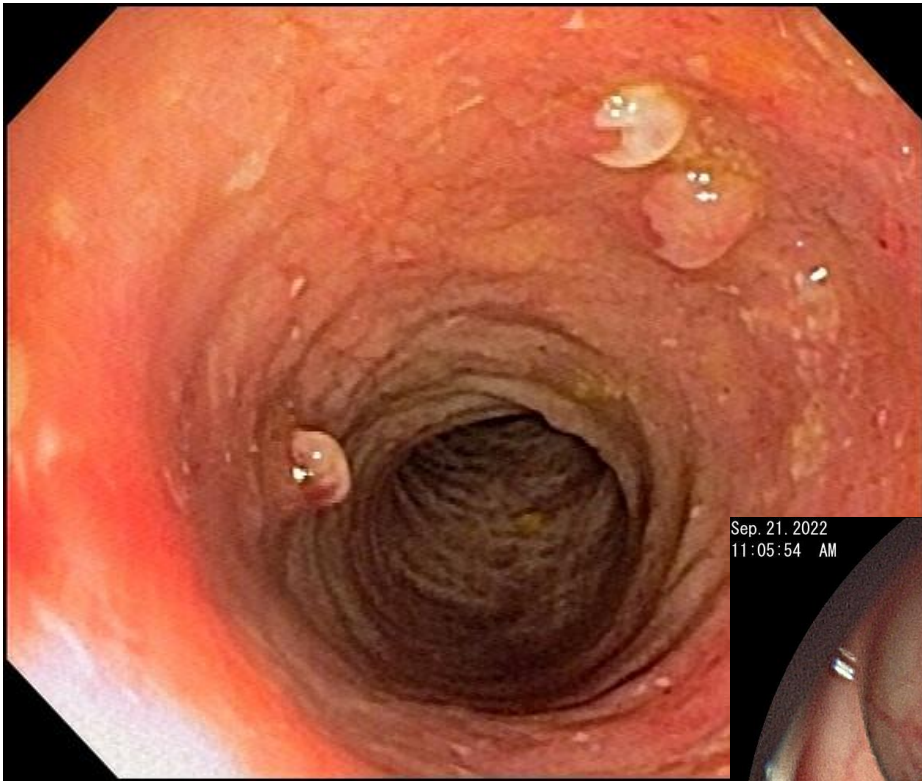


EXEMPLO DE ESTENOSE

FUJINON
2023/05/09
17:04:18



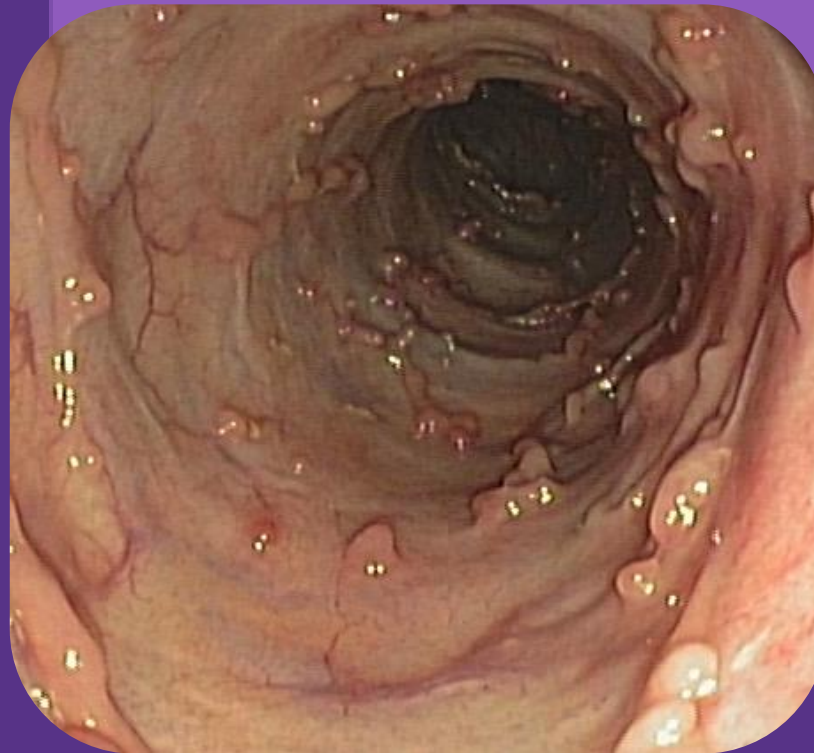
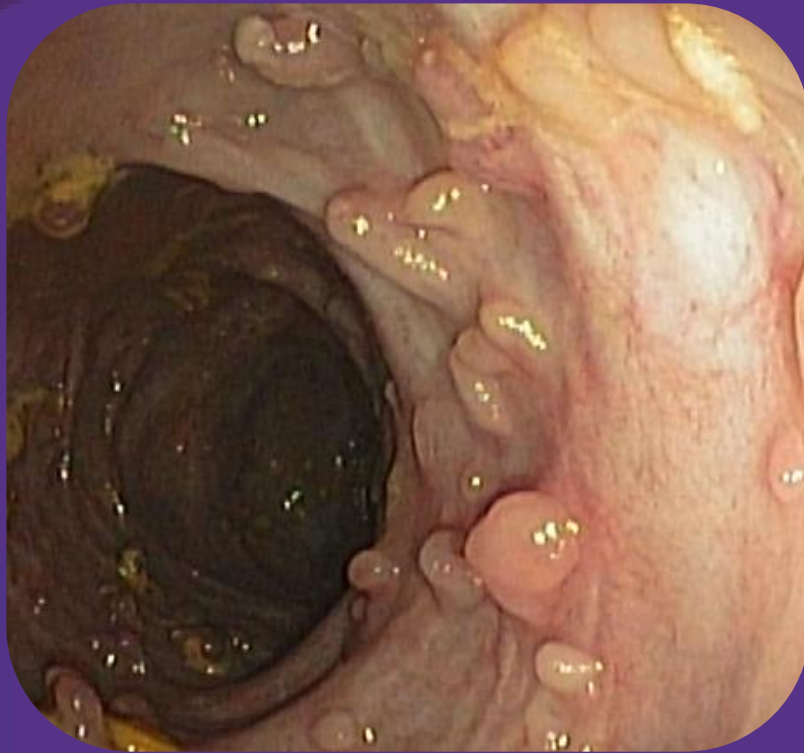
ESTENOSE DE VÁVULA ILEOCECAL + FÍSTULA ILEOCECAL



PSEUDOPÓLIPOS INFLAMATÓRIOS

- LESÃO COM ASPECTO POLIPOIDE
- PODEM SER ISOLADAS OU MÚLTIPLAS
- SUPERFÍCIE LISA
- TAMANHOS VARIADOS, PODENDO INCLUSIVE TER GRANDES DIMENSÕES E PROMOVER OBSTRUÇÃO DA LUZ
- DISTRIBUÍDAS POR TODA EXTENSÃO DO CÓLON

PSEUDOPÓLIPOS INFLAMMATÓRIOS

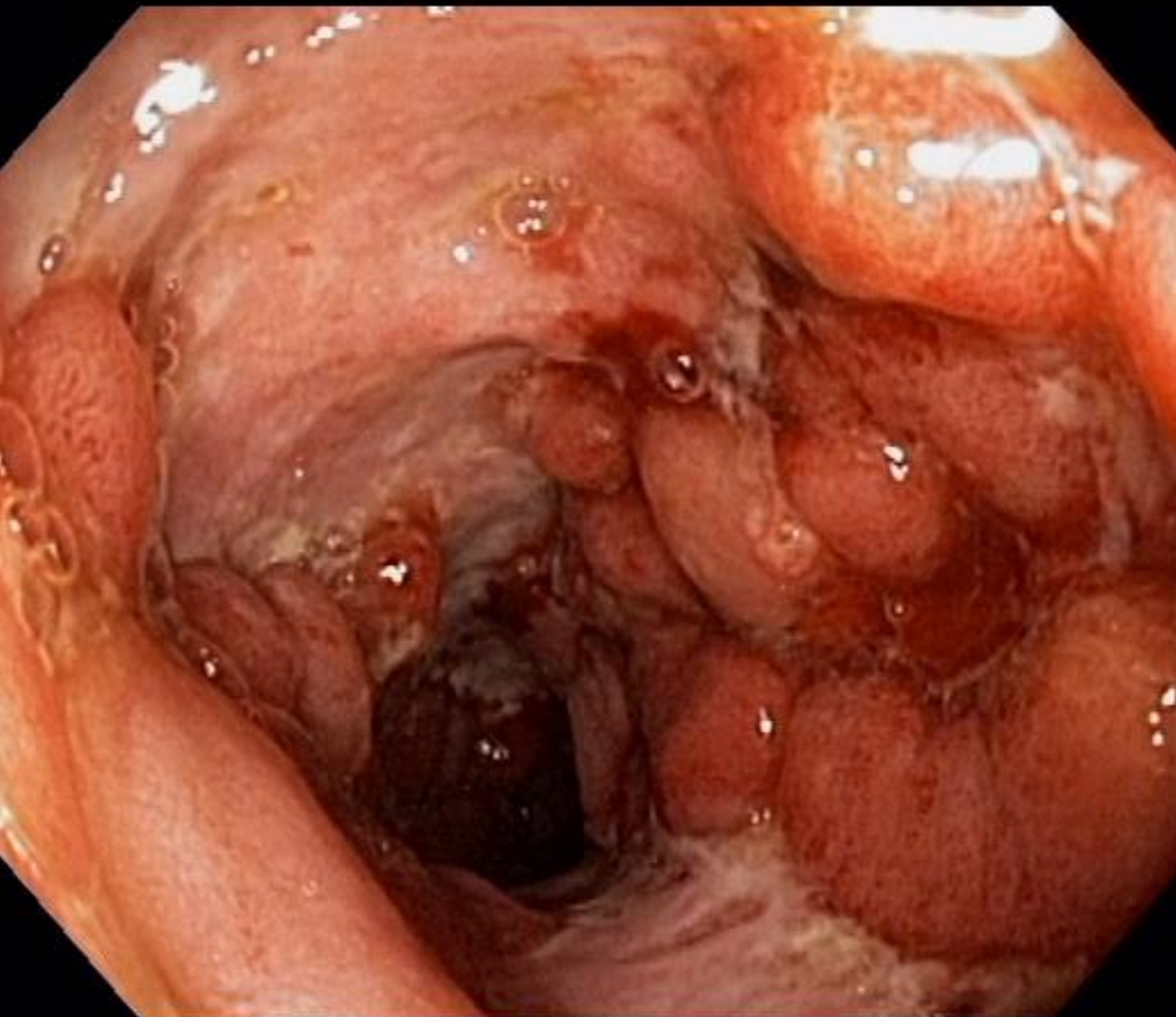




ASPECTO DE PADRAS DE CALÇAMENTO OU COBBLESTONES

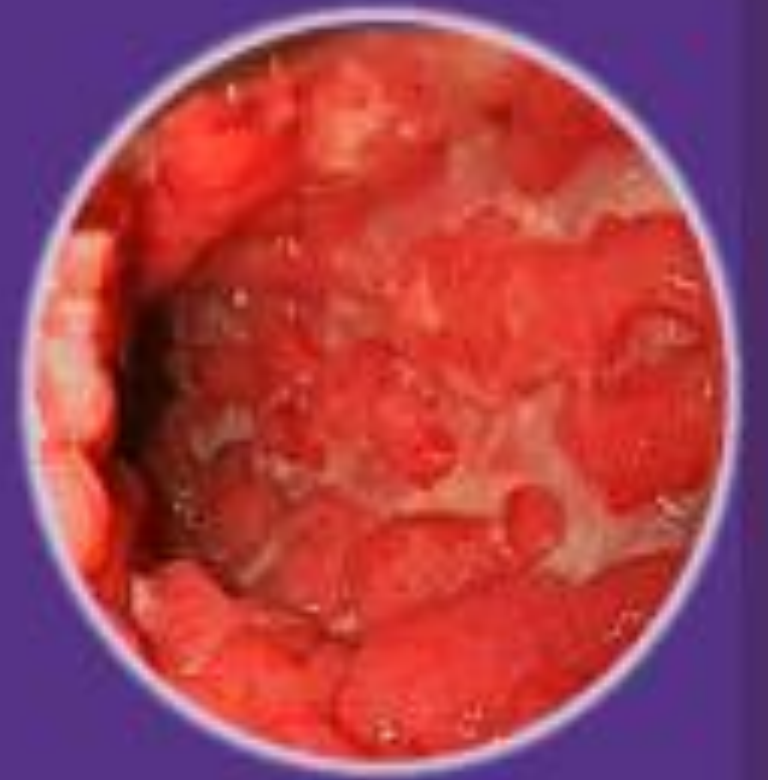
- ASPECTO IRREGULAR DA MUCOSA QUE LEMBRA UMA RUA COM CALÇAMENTO DE PARALELEPÍEDOS.
- ESSE PADRÃO PODE ESTAR ASSOCIADO A MUCOSA REGENERADA, ÚLCERAS LONGITUDINAIS OU SEGMENTOS DE MUCOSA PRESERVADA

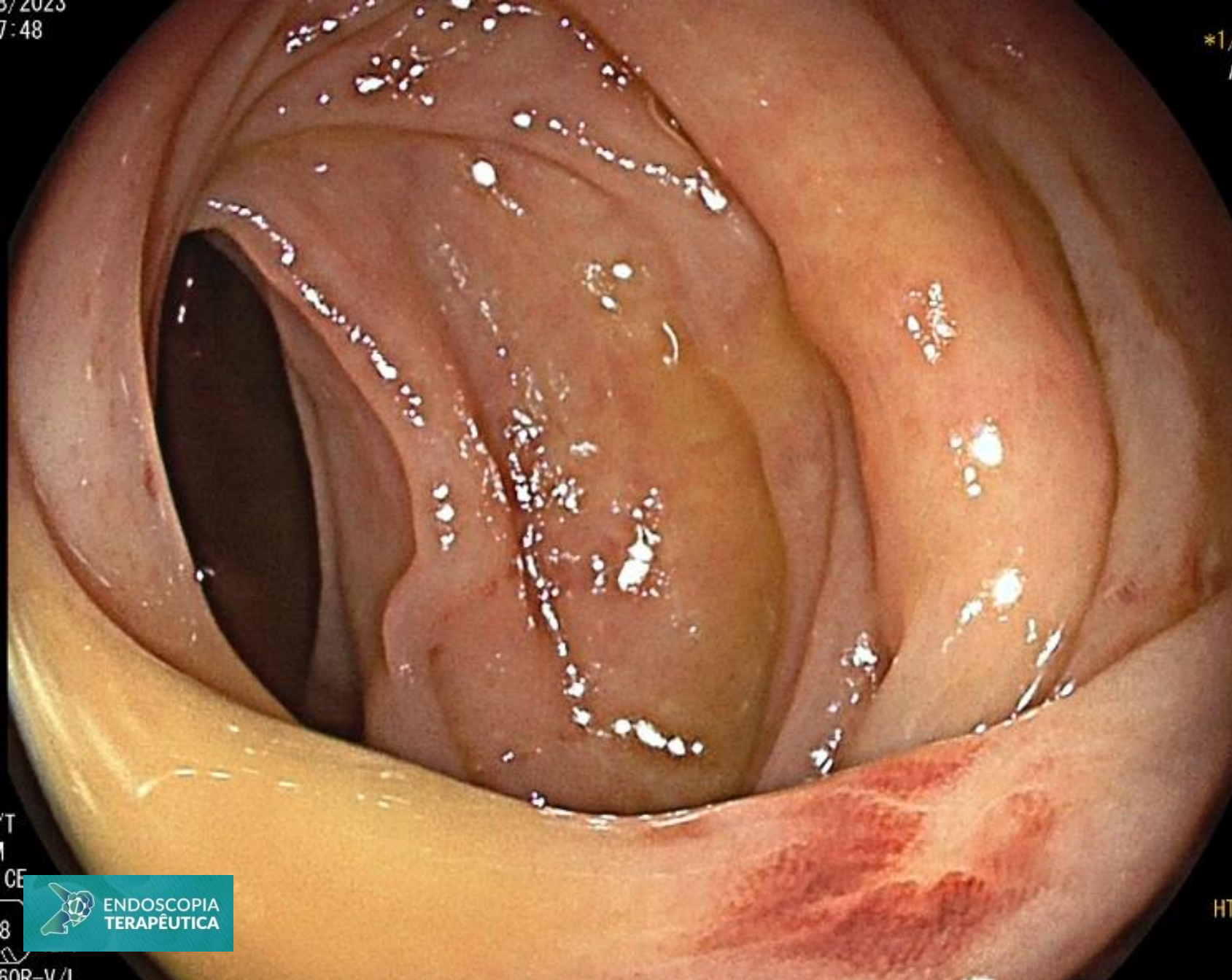




COBBLESTONES OU
PADRÃO TIPO
“PEDRA DE
CALÇAMENTO”

OUTRAS LESÕES DE INTERESSE





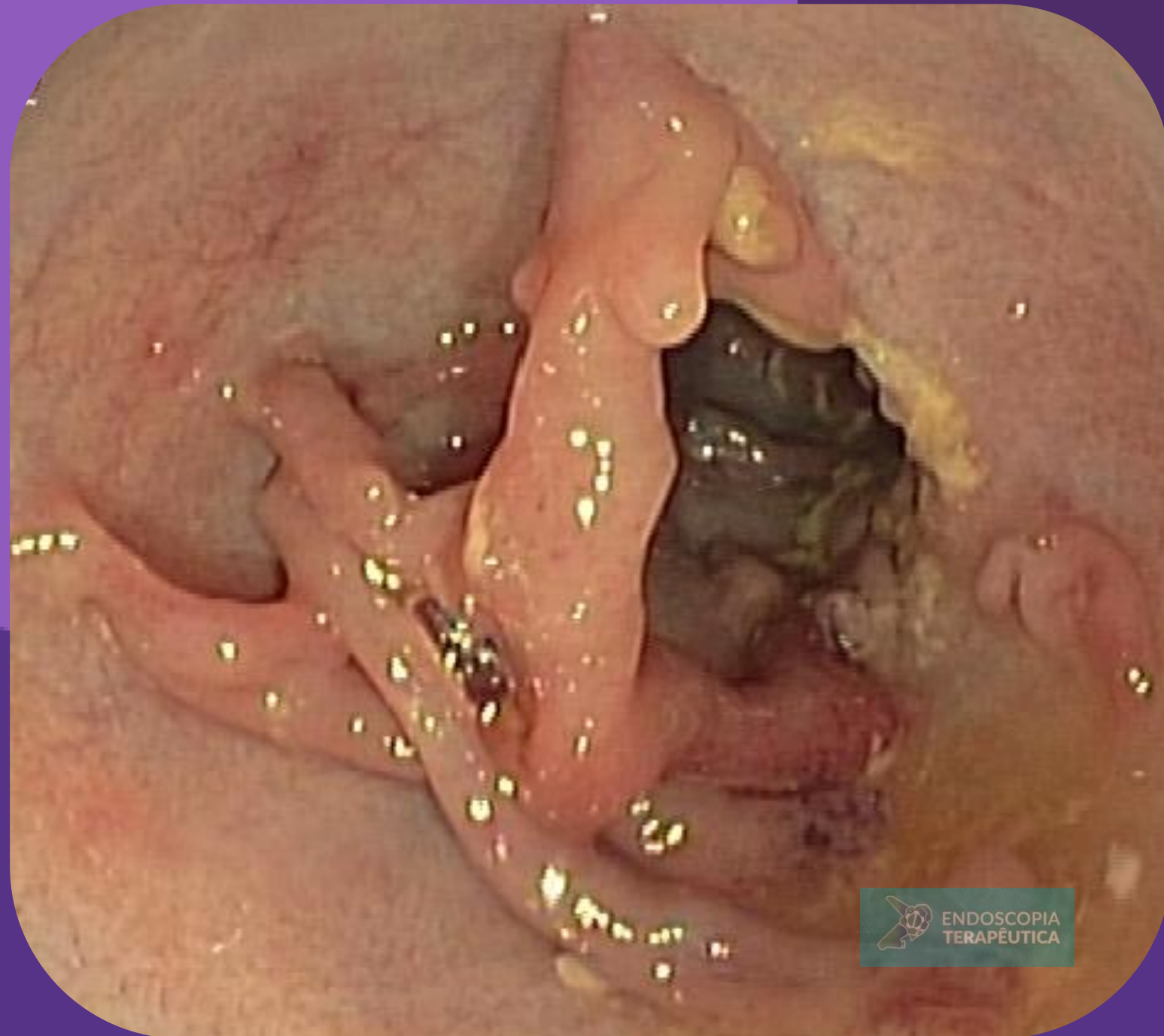
FOLÍCULOS LINFOIDES COM HALO VERMELHO OU SINAL DO ANEL VERMELHO

- ESPECULA-SE QUE FOLÍCULOS LINFOIDES COM HALO VERMELHO PODEM INDICAR O LOCAL INICIAL DA INFLAMAÇÃO, PRINCIPALMENTE EM CASOS DE DOENÇA DE CROHN

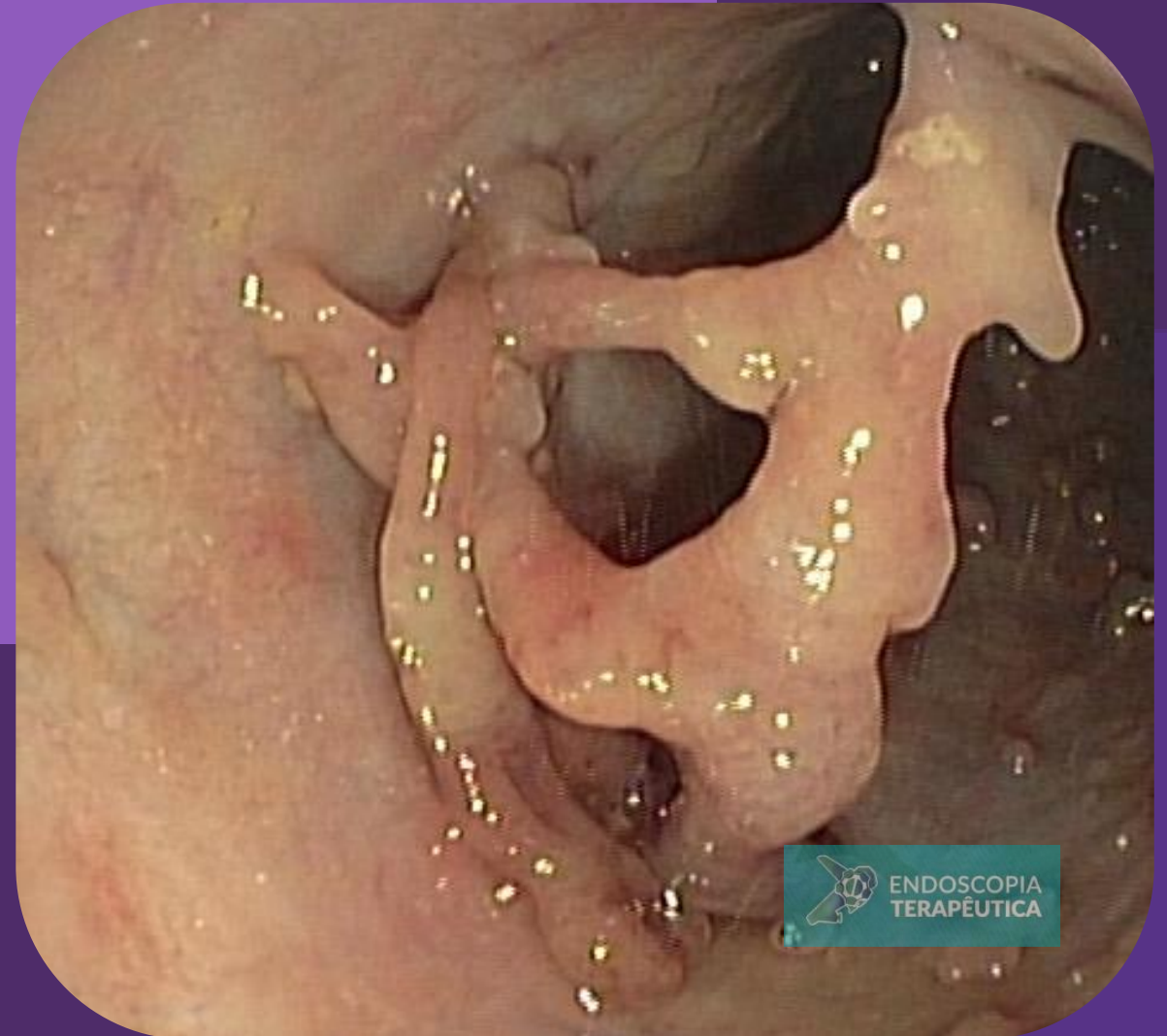
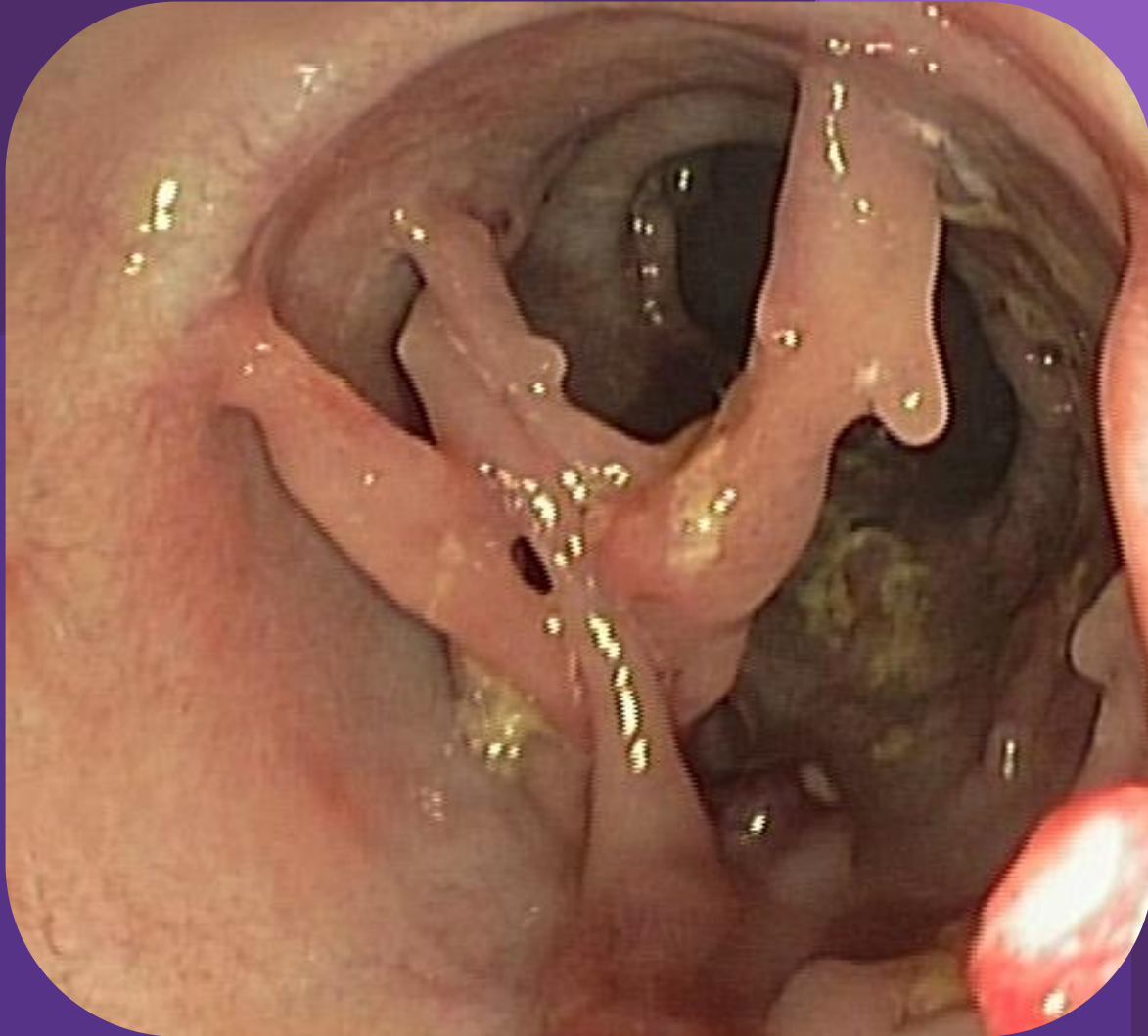
PONTES MUCOSAS

AS PONTES DE MUCOSA SÃO
CONSEQUÊNCIA DA CICATRIZAÇÃO DE
LESÕES ULCERADAS

SÃO MAIS FREQUENTES NA DOENÇA
DE CRONH



PONTES MUCOSAS



ÁREAS CICATRICIAIS COM DISTORÇÃO DOS VASOS

ESSE PADRÃO PODE SER
OBSERVADO APÓS A
CICATRIZAÇÃO DAS LESÕES



ÁREA DE INFLAMAÇÃO NO ÓSTIO APENDICULAR

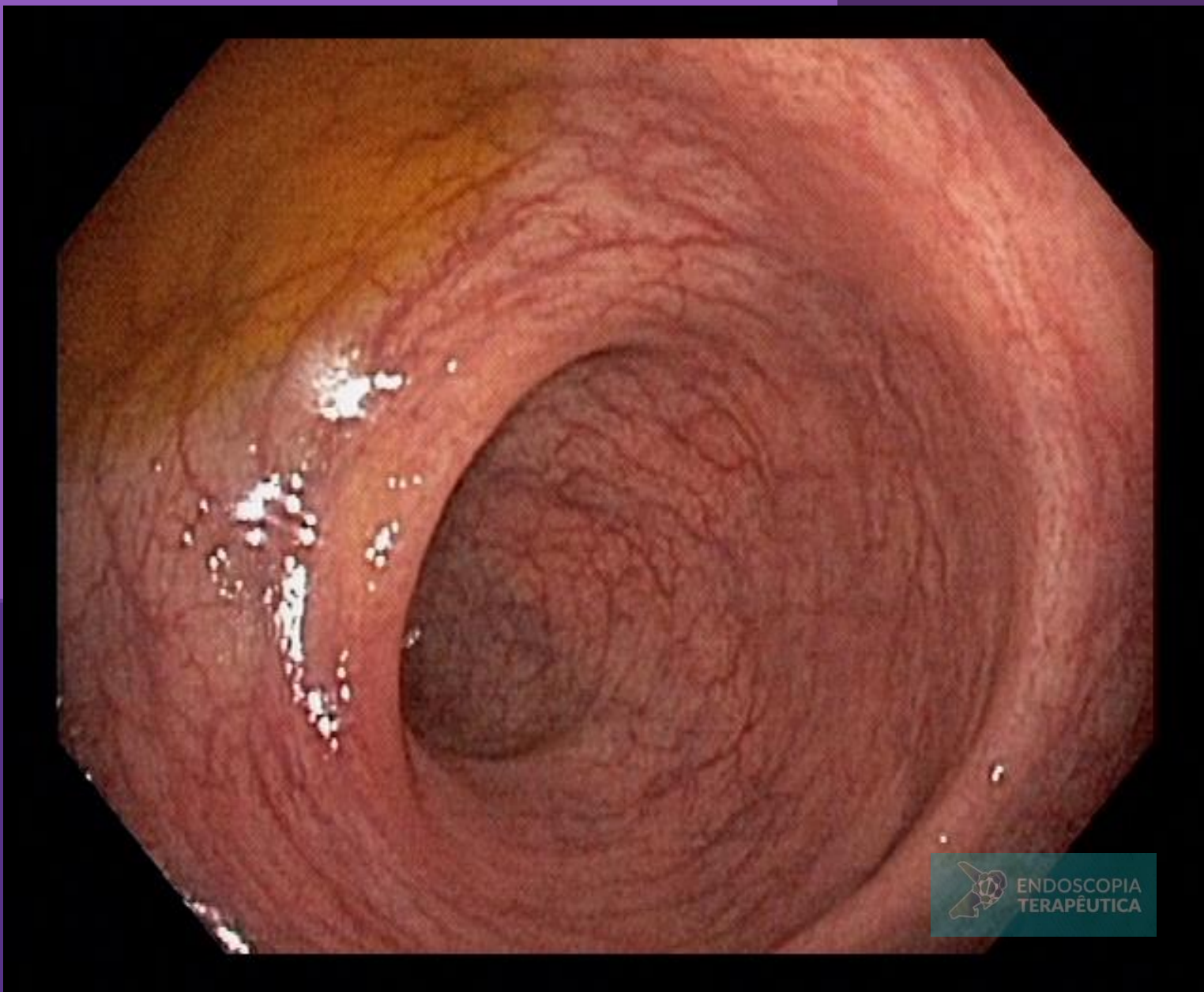
ESSA ALTERAÇÃO INFLAMATÓRIA SEGMENTAR
PODE OCORRER EM PACIENTES PORTADORES
DE RCUI EM CASOS DE COLITE ESQUERDA



RETO “POUPADO” NA RCUI

O RETO PODE SER POUPADO DO
PROCESSO INFLAMATÓRIO EM
ALGUMAS SITUAÇÕES ESPECÍFICAS:

- NOS PACIENTES PORTADORES DE CEP
- EM CRIANÇAS
- NOS PACIENTES QUE FIZERAM TERAPIA TÓPICA COM AMINOSSALICIATOS



ILEÍTE DE REFLUXO

PODE ACONTECER EM 15%
DOS PACIENTES PORTADORES
DE PANCOLITE - RCUI



DOENÇA PERIANAL NA DOENÇA DE CROHN

PLICOMAS GIGANTES
E GROSSEIROS



DOENÇA PERIANAL NA DOENÇA DE CRONH

- ABSCESSO PERIANAL



DOENÇA PERIANAL NA DOENÇA DE CRONH

FÍSTULAS PERIANAIS



DOENÇA PERIANAL NA DOENÇA DE CROHN

- FISSURAS ANAIS COM PADRÃO GROSSEIRO
- MULTIPLICIDADE DAS FISSURAS

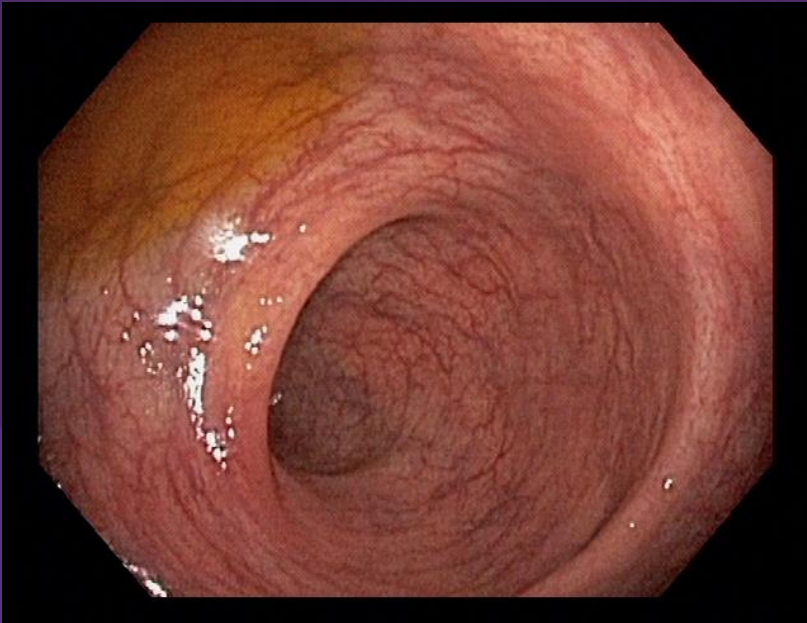




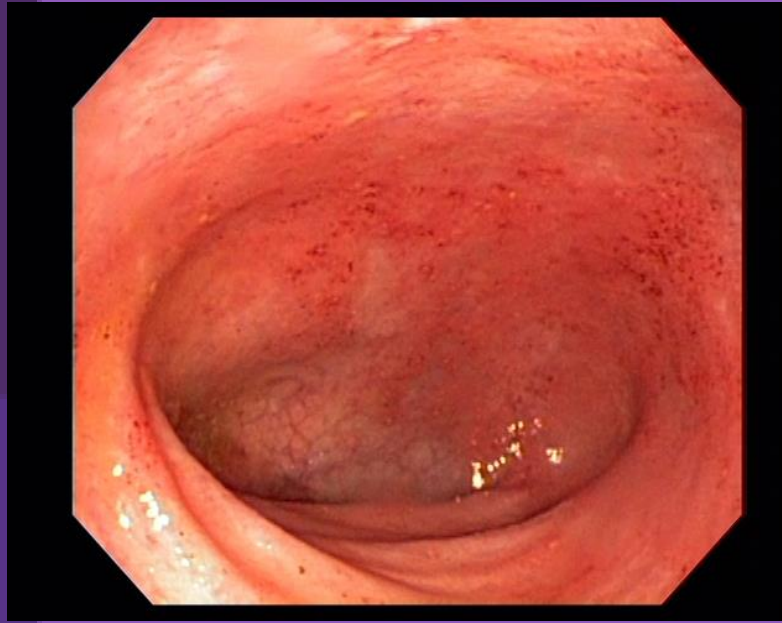
DICAS PRÁTICAS

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL ENTRE DC E RCUI

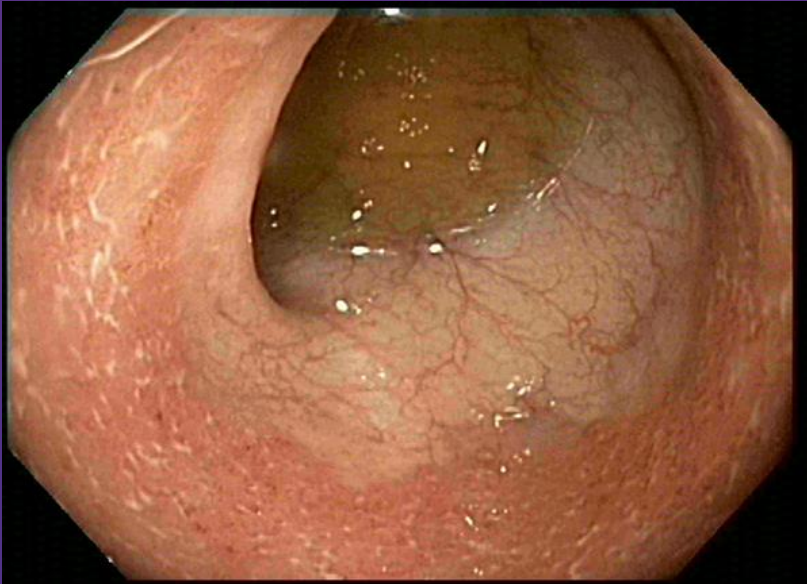
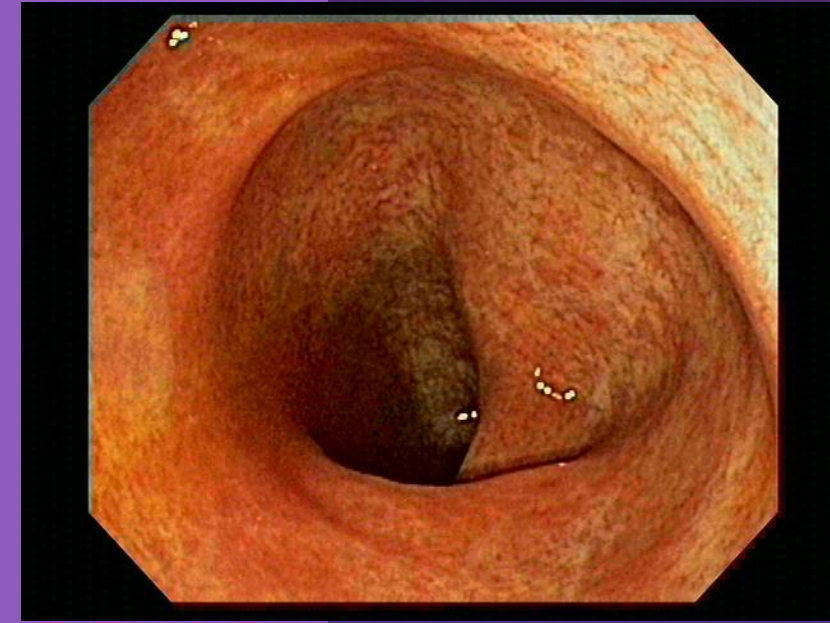
MUCOSA NORMAL



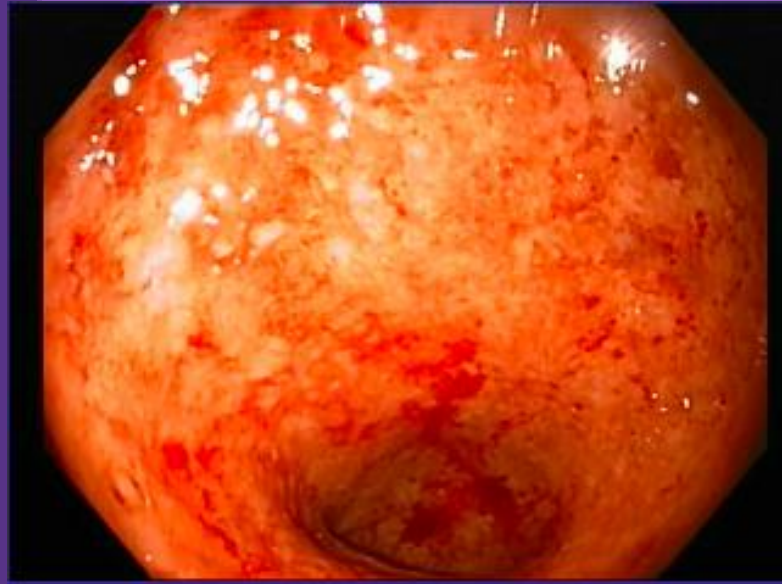
ENANTEMA



TRAMA VASCULAR



GRANULARIDADE

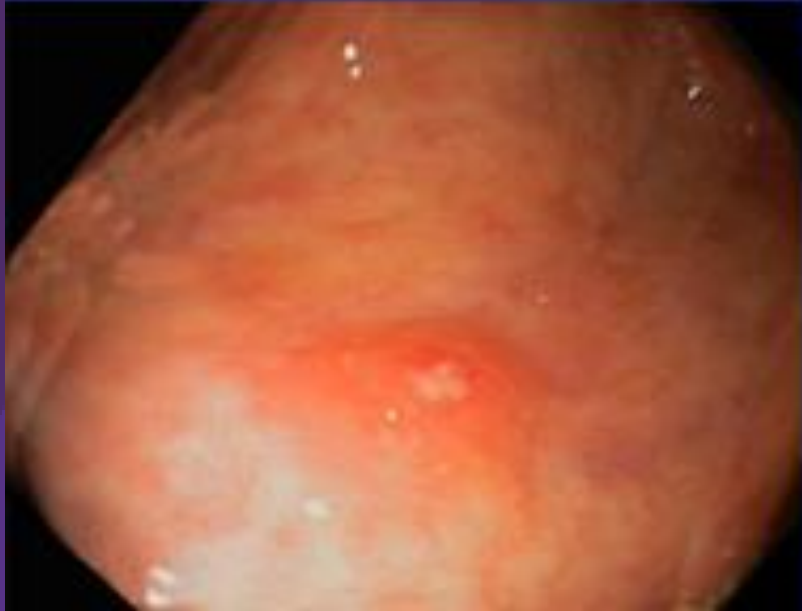


FRIABILIDADE

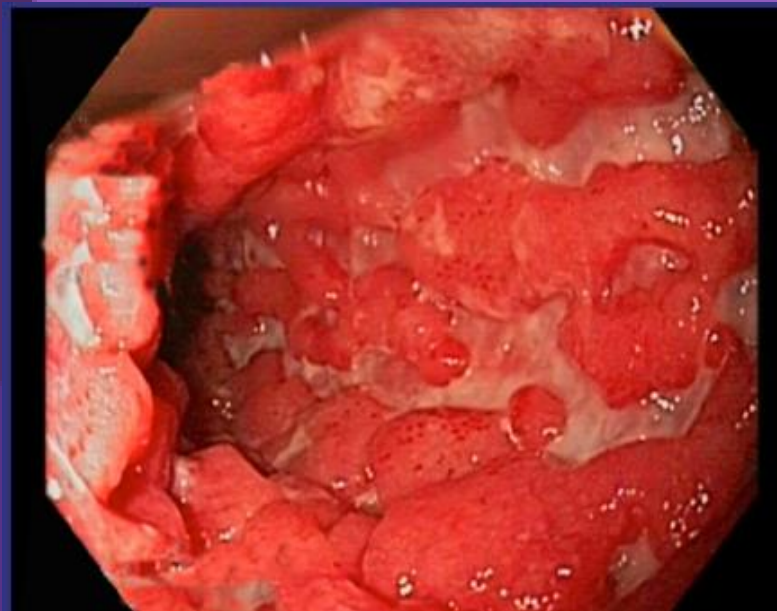


EROSÕES/ULCERAÇÕES

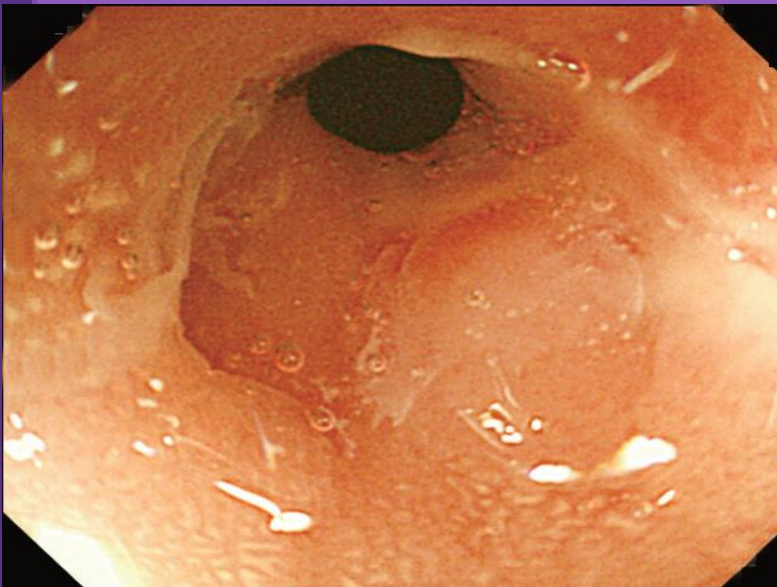
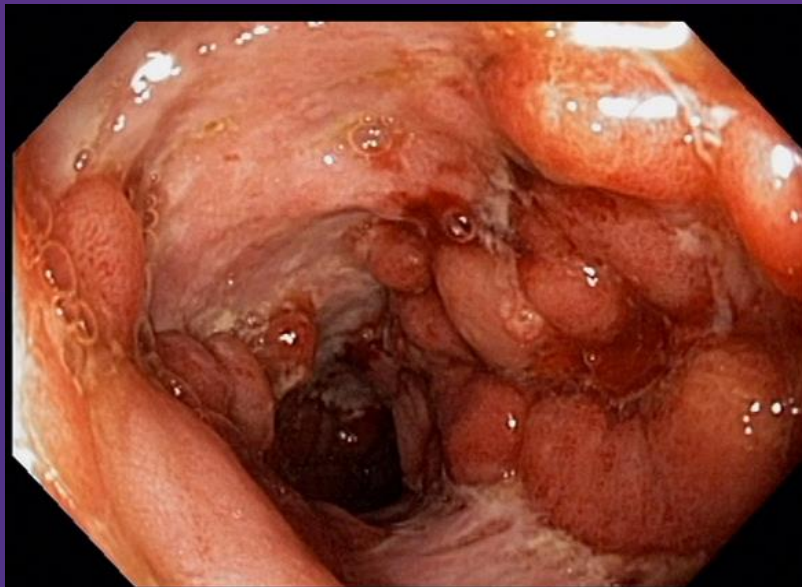
EROSÃO AFTÓIDE



ÚLCERA LONGITUDINAL



ÚLCERA/MUCOSA NORMAL



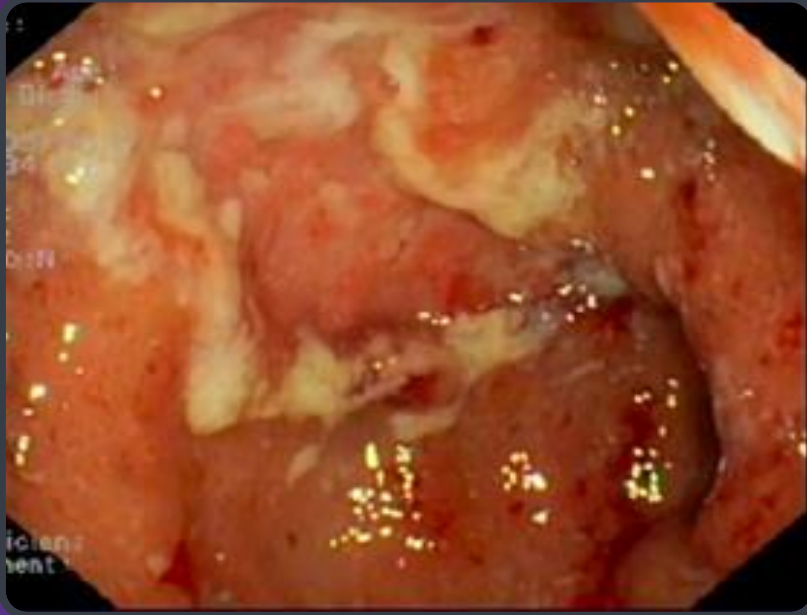
PEDRA EM CALCAMENTO

Licenciado para: Beatriz Teodoro | biat.rangel@hotmail.com | 10236806700 | Protegido por AlpaClass.com #M83Q5yk7zr

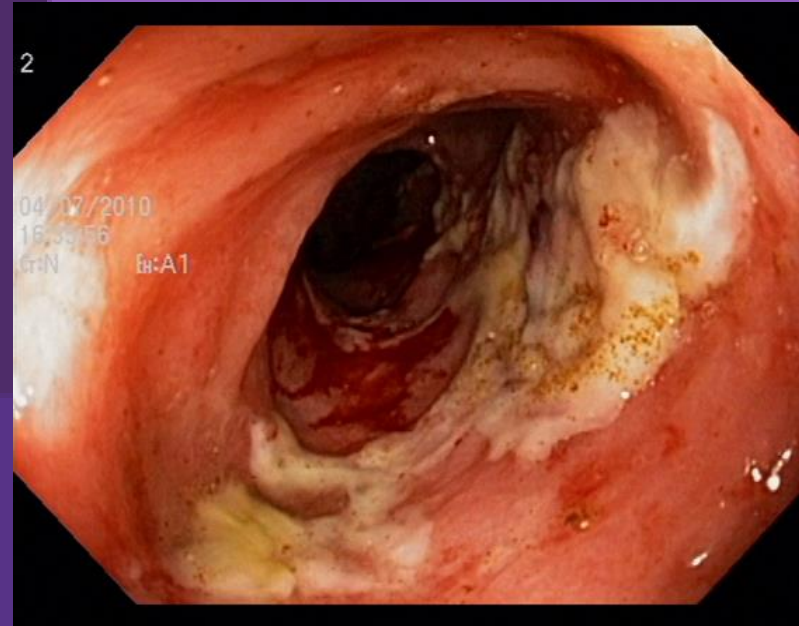
ESTENOSE

ÚLCERA EM ESÔFAGO

COLITE INFECCIOSA



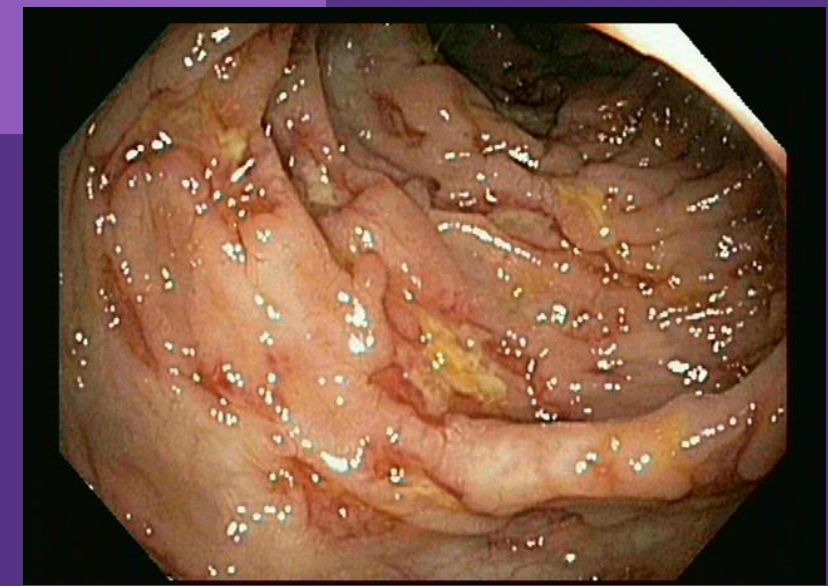
COLITE ISQUÊMICA



AINES



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL



CMV

TUBERCULOSE

DICAS PRÁTICAS PARA AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

RCUI	DOENÇA DE CROHN
RETO QUASE SEMPRE ENVOLVIDO (EXCEÇÕES: CEP, CRIANÇAS E TRATAMENTO LOCAL COM AMINOSSALICILATOS)	GERALMENTE POUPA O RETO
SEM DOENÇA PERIANAL	DOENÇA PERIANAL EXUBERANTE: FÍSTULAS, FISSURAS, PLICOMAS GIGANTES, ABSCESSO PERIANAL
AUSÊNCIA DE ESTENOSE	ESTENOSES
LESÕES TÊM DISTRIBUIÇÃO CONTÍNUA À PARTIR DO RETO	LESÕES TÊM DISTRIBUIÇÃO DESCONTÍNUA DE FORMA MAIS FREQUENTE: SÃO INTERCALADAS COM ÁREAS DE ASPECTO NORMAL
ENANTEMA E ASPECTO GRANULAR DA MUCOSA SÃO MAIS COMUNS	COBBLESTONES
PERDA DO PADRÃO VASCULAR	ÚLCERAS AFTOIDES
ÚLCERAS MAIS SUPERFICIAIS	ÚLCERAS MAIS PROFUNDAS, TORTUOSAS E LONGITUDINAIS
ÍLEO TERMINAL GERALMENTE POUPADO	ÍLEO TERMINAL COM ULCERAÇÕES